Estilo UERJ

Simulado 11 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	15	4, 6, 12, 13, 18, 19, 21, 26, 29, 34, 37, 40, 45, 48, 49
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	7	1, 8, 14, 16, 20, 27, 32
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	1	43
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	3	11, 31, 46
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	9	7, 10, 15, 22, 23, 39, 41, 44, 47
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	7	3, 5, 28, 35, 36, 38, 50
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	5	9, 24, 30, 33, 42
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	3	2, 17, 25

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **C**	2 **A**	3 **D**	4 **A**	5 **B**	6 **C**	7 **A**	8 **B**	9 **B**	10 **D**
11 **C**	12 **B**	13 **D**	14 **D**	15 **D**	16 **D**	17 **C**	18 **A**	19 **C**	20 **A**
21 **A**	22 **C**	23 **A**	24 **C**	25 **C**	26 **B**	27 **C**	28 **A**	29 **A**	30 **A**
31 **D**	32 **B**	33 **B**	34 **D**	35 **C**	36 **B**	37 **D**	38 **C**	39 **B**	40 **C**
41 **D**	42 **B**	43 **B**	44 **D**	45 **A**	46 **A**	47 **A**	48 **B**	49 **B**	50 **D**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Infectologia · Uretrite persistente após ceftriaxona e azitromicina em dose única, com testes moleculares negativos: Mycoplasma genitalium

Negativo no meio

Gabarito C

Homem de 26 anos, que faz sexo com homens, foi tratado há 3 semanas por uretrite com secreção mucopurulenta, com ceftriaxona 500 mg IM e azitromicina 1 g VO em dose única. Tomou corretamente, o parceiro fixo foi tratado com o mesmo esquema e nega nova exposição. Persiste com disúria e secreção uretral escassa e clara desde então. Bacterioscopia da secreção: mais de 5 polimorfonucleares por campo, sem diplococos gram-negativos. Os testes moleculares para gonococo e clamídia, colhidos agora, são negativos, assim como o teste molecular para Trichomonas vaginalis. Sem úlceras, sem lesões perianais; sorologias para sífilis e HIV não reagentes. O agente mais provável da persistência é:

O DADO QUE DECIDE

Os testes moleculares para gonococo e clamídia, colhidos agora, são negativos

Resolução. Uretrite que não melhora depois da ceftriaxona faz pensar em gonococo resistente, que é a preocupação de saúde pública do momento, e a clamídia é o agente mais frequente de uretrite não gonocócica. Mas os testes moleculares colhidos agora, negativos para os dois, e a bacterioscopia sem diplococos afastam ambos, e o teste para Trichomonas também foi negativo. A uretrite persistente com inflamação confirmada, após azitromicina em dose única e sem reexposição, é Mycoplasma genitalium até prova em contrário: o agente responde mal à azitromicina em dose única, que ainda seleciona resistência a macrolídeos. O tratamento é guiado pela resistência quando disponível; empiricamente, doxiciclina seguida de moxifloxacino. Herpes dá uretrite com disúria intensa e lesões ou linfonodos, e não secreção persistente isolada.

A) Neisseria gonorrhoeae resistente ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria o agente com diplococos gram-negativos na bacterioscopia ou teste molecular positivo, ambos ausentes.

B) Chlamydia trachomatis

Errada. É o agente mais comum da uretrite não gonocócica, mas o teste molecular colhido agora é negativo, e a azitromicina costuma tratá-la.

C) Mycoplasma genitalium CORRETA

Correta. Uretrite persistente com polimorfonucleares após azitromicina em dose única, com gonococo, clamídia e tricomonas negativos, aponta o micoplasma.

D) Herpes simples tipo 2

Errada. Herpes causa uretrite com dor intensa, vesículas ou úlceras e linfadenomegalia, e não secreção clara persistente após antibiótico.

Para levar. Uretrite persistente com testes negativos para gonococo, clamídia e tricomonas, após azitromicina em dose única, é Mycoplasma genitalium: tratar com doxiciclina seguida de moxifloxacino.

Ministério da Saúde, PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022); CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021).

2

Hematologia · Linfocitose persistente em idoso atribuída a quadro gripal recente: imunofenotipagem do sangue periférico, sem medula nem tomografia

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 71 anos, assintomático, traz hemograma de rotina: Hb 13,6 g/dL, leucócitos 21.400/mm³, linfócitos 17.600/mm³, neutrófilos 3.300/mm³, plaquetas 182.000/mm³. O clínico atribuiu a linfocitose a um quadro gripal de 1 mês atrás. Hemograma de 5 meses atrás, feito para cirurgia de catarata, mostrava leucócitos 16.900/mm³ e linfócitos 12.800/mm³. Nega febre, sudorese noturna ou perda de peso. Exame físico sem linfonodomegalias palpáveis, sem hepatomegalia ou esplenomegalia. Esfregaço: linfócitos pequenos, de cromatina condensada, com numerosas células esmagadas. LDH e função renal normais. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Hemograma de 5 meses atrás

Resolução. O quadro gripal recente é verdadeiro e oferece a explicação confortável de linfocitose reacional, o que levaria a repetir o hemograma. Mas a cronologia derruba essa leitura: a linfocitose já existia 5 meses antes da virose e vem subindo, e linfocitose reacional é transitória e de linfócitos ativados, não de linfócitos pequenos maduros com células esmagadas (sombras de Gumprecht). Linfocitose B persistente acima de 5.000/mm³ em idoso é leucemia linfocítica crônica (LLC) até prova em contrário, e o diagnóstico se faz no sangue, com imunofenotipagem por citometria de fluxo (CD5, CD19, CD20 fraco, CD23, cadeia leve restrita). Mielograma, biópsia de medula e tomografia não são necessários para diagnosticar nem para estadiar a LLC assintomática (Rai e Binet são clínicos), e só entram em situações específicas, como citopenia de causa incerta antes de tratar.

A) Imunofenotipagem do sangue periférico CORRETA
Correta. Linfocitose persistente e crescente de linfócitos maduros em idoso: a citometria de fluxo do sangue confirma clonalidade e fenótipo de LLC.

B) Repetir hemograma em 4 semanas ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria razoável numa linfocitose nova após virose; aqui ela antecede a virose em 5 meses.

C) Biópsia de medula óssea
Errada. Medula não é necessária para o diagnóstico da LLC; reserva-se para citopenia sem causa clara ou antes de tratar em casos selecionados.

D) TC de tórax, abdome e pelve
Errada. O estadiamento da LLC é clínico (Rai e Binet); tomografia não está indicada no assintomático sem sinais de transformação.

Para levar. Linfocitose persistente de linfócitos maduros no adulto: imunofenotipagem do sangue periférico é o exame que diagnostica LLC; medula e tomografia não fazem parte do diagnóstico nem do estadiamento.

iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL (Hallek et al., Blood 2018).

---

3 Cardiologia · Hipotensão ortostática no diabético em uso de tiazídico: a frequência que não sobe define a causa neurogênica

Limiar **Gabarito D**

Homem de 71 anos, com diabetes tipo 2 há 22 anos (HbA1c 8,9%), retinopatia proliferativa e parestesias em bota, e hipertensão tratada com hidroclorotiazida 25 mg e losartana 50 mg, relata tontura ao se levantar, pior pela manhã e após o almoço, com duas quedas no último mês. Nega vômitos, diarreia ou redução da ingestão de líquidos; peso estável. Sem tremor, rigidez, bradicinesia ou ataxia; sem uso de alfabloqueador. Deitado há 5 minutos: PA 168×94 mmHg e FC 74 bpm. Após 3 minutos em pé: PA 126×78 mmHg e FC 77 bpm. Ureia 36 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL (igual à de 6 meses atrás), sódio 138 mEq/L, potássio 4,2 mEq/L, glicemia 164 mg/dL, Hb 13,6 g/dL. A filha atribui as quedas 'ao diurético, que desidrata'. A causa mais provável da hipotensão ortostática é:

O DADO QUE DECIDE

Após 3 minutos em pé: PA 126×78 mmHg e FC 77 bpm

Resolução. A queda de 42 mmHg na sistólica confirma a hipotensão ortostática, e o tiazídico é um culpado verdadeiro e conveniente, por isso é a isca. O dado que separa as causas é a resposta da frequência: na hipovolemia o barorreflexo está íntegro e a FC sobe 15 a 30 bpm; na disautonomia a FC quase não se mexe. A razão entre o aumento da FC e a queda da sistólica abaixo de 0,5 bpm/mmHg indica causa neurogênica, e aqui ela é 3/42, cerca de 0,07. Somam-se a hipertensão supina, a piora pós-prandial e pela manhã, a retinopatia e a polineuropatia de longa data, que fazem da neuropatia autonômica diabética a causa. Ureia e creatinina estáveis, sódio normal e peso mantido não sustentam depleção de volume. Reduzir ou suspender o tiazídico pode ajudar, mas não corrige a causa, e tratar a hipertensão supina com o paciente deitado é parte do manejo.

A) Insuficiência adrenal primária
Errada. Insuficiência adrenal primária daria hiponatremia, hiperpotassemia e taquicardia compensatória, além de hipotensão também em decúbito; aqui sódio e potássio são normais e há hipertensão supina.

B) Atrofia de múltiplos sistemas
Errada. A atrofia de múltiplos sistemas também causa hipotensão neurogênica, mas exige parkinsonismo ou síndrome cerebelar, explicitamente ausentes; o diabetes de longa data com retinopatia e neuropatia já explica tudo.

C) Depleção de volume pelo tiazídico ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Na depleção de volume a FC subiria pelo menos 15 bpm em pé, e a função renal, o sódio e o peso mudariam; a FC subiu 3 bpm.

D) Neuropatia autonômica diabética CORRETA
Correta. Queda de 42 mmHg com aumento de 3 bpm (razão bem abaixo de 0,5) indica falha barorreflexa, e a microangiopatia e a neuropatia de longa data apontam a causa diabética.

Para levar. Na hipotensão ortostática, olhe a FC: aumento menor que 0,5 bpm para cada mmHg de queda da sistólica indica causa neurogênica; hipovolemia e drogas mantêm a taquicardia compensatória.

Consenso AAS/EFAS sobre hipotensão ortostática neurogênica (Freeman R et al., Clin Auton Res 2018); ESC 2018 Guidelines for syncope; ADA Standards of Care 2026 (neuropatia autonômica)

4

Oncologia · Hiperviscosidade sintomática no mieloma IgA com hemoglobina muito baixa: plasmaférese antes de transfundir

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Homem de 66 anos, com mieloma múltiplo IgA kappa diagnosticado há 1 semana e quimioterapia ainda não iniciada, é trazido por cefaleia, visão turva, epistaxe recorrente e sonolência há 2 dias. PA 150×90 mmHg, FC 96 bpm, SatO2 95%, sem dispneia, sem dor torácica, sem estertores. Fundoscopia: veias retinianas dilatadas e tortuosas, com hemorragias em chama de vela. Exames: Hb 6,8 g/dL, plaquetas 110.000/mm³, creatinina 1,6 mg/dL, cálcio corrigido 10,2 mg/dL, proteínas totais 12,4 g/dL, componente monoclonal IgA de 6,8 g/dL, hemácias empilhadas no esfregaço. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

veias retinianas dilatadas e tortuosas, com hemorragias em chama de vela

Resolução. A hemoglobina de 6,8 g/dL é verdadeira e grita transfusão. Mas o quadro neurológico, a epistaxe e a fundoscopia com veias em salsicha e hemorragias são hiperviscosidade: a IgA tende a formar dímeros e polímeros e, em concentração alta, aumenta muito a viscosidade do plasma. Nessa situação a anemia é em parte dilucional e protege, porque o hematócrito baixo reduz a viscosidade total; transfundir antes de retirar a proteína aumenta a viscosidade e pode precipitar AVC, infarto ou insuficiência cardíaca. A emergência é a plasmaférese, que reduz a paraproteína em horas, seguida do tratamento do mieloma; a transfusão, se ainda necessária, vem depois e de forma lenta. Dexametasona inicia o controle do clone, mas não reduz a viscosidade a tempo. Filtro de alto ponto de corte remove cadeias leves no rim do mieloma, não IgA.

A) Plasmaférese antes de qualquer transfusão CORRETA
Correta. Hiperviscosidade sintomática pede plasmaférese de urgência; transfundir antes aumenta a viscosidade.

B) Transfusão de dois concentrados de hemácias ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a transfusão seria a conduta na anemia grave sem hiperviscosidade; aqui pode agravar a síndrome.

C) Dexametasona em dose alta isolada
Errada. Faz parte do tratamento do mieloma, mas não baixa a paraproteína com a rapidez que a emergência exige.

D) Hemodiálise com filtro de alto ponto de corte
Errada. Seria considerado no rim do mieloma por cadeias leves; não remove IgA nem trata hiperviscosidade.

Para levar. Hiperviscosidade sintomática: plasmaférese primeiro; transfusão de hemácias só depois e com cautela, porque eleva a viscosidade.

ASFA Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis (2023); IMWG recommendations on emergencies in multiple myeloma; NCCN Multiple Myeloma (2025)

---

5 Emergência · Parada em fibrilação ventricular na hipotermia grave: potássio abaixo do limiar de futilidade, manter RCP e levar à ECMO

Limiar **Gabarito B**

Homem de 74 anos, em situação de rua, é encontrado inconsciente e molhado numa madrugada de inverno. A equipe constata ausência de pulso, com fibrilação ventricular no monitor; temperatura esofágica de 26 °C. Recebeu três choques sem sucesso e está em RCP de alta qualidade há 40 minutos, sem retorno da circulação. Não há trauma, rigidez nem lesão incompatível com a vida. Gasometria: pH 7,08, potássio 5,4 mEq/L (ref. 3,5 a 5,0). Há hospital com ECMO a 25 minutos. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

potássio 5,4 mEq/L

Resolução. Quarenta minutos de RCP sem retorno, idoso, pH ácido: tudo puxa para encerrar. Na hipotermia, porém, o cérebro frio tolera longos períodos de baixo fluxo, e o critério de futilidade não é o tempo, mas o potássio: acima de 12 mmol/L (marcador de lise celular e asfixia) a sobrevida é praticamente nula; 5,4 está muito abaixo disso. Sem trauma letal, a conduta é manter compressões contínuas (dispositivo mecânico se houver) e transportar para reaquecimento extracorpóreo, o método de escolha na parada por hipotermia. Abaixo de 30 °C, depois de três choques, novos choques e drogas são suspensos até o reaquecimento, porque o miocárdio frio não responde e as drogas se acumulam; entre 30 e 35 °C os intervalos das drogas são dobrados.

A) Encerrar a reanimação pelo tempo ARMADILHA
Errada. Seria a decisão com potássio acima de 12 mmol/L ou lesão incompatível; tempo de RCP não define futilidade no paciente hipotérmico.

B) Manter RCP e transferir para ECMO CORRETA
Correta. Hipotermia de 26 °C com potássio de 5,4: RCP contínua e reaquecimento extracorpóreo.

C) Novos choques e amiodarona a cada ciclo
Errada. Abaixo de 30 °C, após três choques, não se repetem choques nem antiarrítmicos até reaquecer acima de 30 °C.

D) Adrenalina a cada 3 a 5 minutos
Errada. Adrenalina é suspensa abaixo de 30 °C; acima disso, com intervalo dobrado até 35 °C.

Para levar. Ninguém está morto até estar quente e morto: na parada por hipotermia o limiar de futilidade é potássio acima de 12 mmol/L, não o tempo; abaixo de 30 °C, três choques no máximo e nada de drogas até reaquecer.

ERC Guidelines 2021, Cardiac arrest in special circumstances (hipotermia acidental); AHA 2020 e atualização focada de 2023.

6

Reumatologia · Vasculite crioglobulinêmica que recidiva com RNA do HCV indetectável após a cura: clone B autônomo, rituximabe com glicocorticoide, e não novo antiviral

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Mulher de 64 anos teve vasculite crioglobulinêmica pela hepatite C, com púrpura e artralgia, e foi tratada com sofosbuvir e velpatasvir há 2 anos, com RNA do HCV indetectável 12 semanas após o fim do tratamento e em duas dosagens posteriores; a púrpura desapareceu na época. Há 3 meses voltou a ter púrpura palpável nas pernas e artralgia de mãos e, há 3 semanas, pé caído à direita e parestesia dolorosa na mão esquerda. Nega uso de drogas injetáveis, nova parceria sexual e procedimentos invasivos. Exame físico: PA 132 × 80 mmHg, púrpura palpável em pernas, fraqueza da dorsiflexão do pé direito, hipoestesia no território do ulnar esquerdo, sem linfonodomegalias e sem esplenomegalia. Exames: creatinina 0,8 mg/dL, urina sem hematúria ou proteinúria, C4 4 mg/dL (VR 10 a 40), fator reumatoide 410 UI/mL, crioglobulinas positivas com criócrito de 5%, RNA do HCV indetectável hoje, HBsAg e anti-HIV não reagentes, LDH normal. Eletroneuromiografia: mononeuropatia múltipla axonal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

RNA do HCV indetectável hoje

Resolução. O antecedente de hepatite C é verdadeiro e puxa para a ideia de recaída viral e de um novo ciclo de antiviral. Mas o RNA está indetectável de forma sustentada, inclusive hoje, e a resposta virológica sustentada equivale a cura em mais de 99% dos casos. A vasculite crioglobulinêmica persiste ou recidiva em parte dos pacientes depois da cura porque o clone de linfócitos B que produz o fator reumatoide monoclonal ganhou autonomia e não depende mais do vírus (fator reumatoide alto e C4 consumido mostram que a crioglobulina mista continua sendo produzida). Com manifestação grave, como a mononeuropatia múltipla, o tratamento se dirige ao clone B: rituximabe associado a glicocorticoide. Plasmaférese fica como ponte nas formas com risco de vida, e glicocorticoide isolado controla púrpura e artralgia, mas não a neuropatia. Antes do rituximabe, vale afastar linfoma B, evolução temida do clone persistente.

A) Prednisona isoladamente
Errada. Basta para púrpura e artralgia leves; com mononeuropatia múltipla, não controla o clone B que produz a crioglobulina.

B) Plasmaférese isoladamente
Errada. Seria ponte nas formas com risco de vida (glomerulonefrite rapidamente progressiva, vasculite intestinal, hiperviscosidade); isolada, o efeito é transitório.

C) Rituximabe com glicocorticoide CORRETA
Correta. Vasculite crioglobulinêmica grave que persiste após a cura do HCV depende do clone B autônomo: rituximabe com glicocorticoide.

D) Novo ciclo de antiviral de ação direta ARMADILHA
Errada. Seria a conduta se houvesse viremia (recaída ou reinfecção); com RNA indetectável sustentado, o antiviral não tem alvo.

Para levar. Vasculite crioglobulinêmica que volta depois da cura do HCV, com RNA indetectável, é clone B autônomo: com manifestação grave, rituximabe com glicocorticoide, e não novo antiviral; afaste linfoma.

Cacoub P, Saadoun D. Extrahepatic manifestations of chronic HCV infection (N Engl J Med, 2021); EASL recommendations on treatment of hepatitis C: final update of the series (2020); KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for the Prevention, Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Hepatitis C in CKD.

7

Nefrologia · Hiponatremia pós-traumatismo craniano que piora com salina isotônica · SIADH, e não perda cerebral de sal, e salina a 3%

Grade X / Y

Gabarito A

Homem de 34 anos, no oitavo dia de internação por traumatismo cranioencefálico (contusão frontal, sem cirurgia), em uso de levetiracetam e dieta enteral. O sódio caiu de 138 para 129 mEq/L em quatro dias, e a equipe, suspeitando de perda cerebral de sal, iniciou salina a 0,9% a 125 mL/h. Após 24 horas e 3 L de salina, o sódio está em 126 mEq/L e o paciente ficou mais sonolento, sem convulsões. Peso 0,8 kg acima do da véspera, balanço hídrico positivo de 900 mL no período, FC 76 bpm, PA 128/80 mmHg, sem hipotensão postural, hematócrito de 40% para 39%, ureia 18 mg/dL. Osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 610 mOsm/kg, sódio urinário 168 mEq/L, potássio urinário 44 mEq/L, ácido úrico 2,4 mg/dL, cortisol e TSH normais. O mecanismo da hiponatremia e a conduta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Após 24 horas e 3 L de salina, o sódio está em 126 mEq/L

Resolução. O traumatismo craniano e a natriurese de 168 mEq/L são verdadeiros e puxam para a perda cerebral de sal, e foi com esse raciocínio que a equipe deu salina. A resposta ao teste terapêutico é que decide: depois de 3 L de salina a 0,9% (cerca de 308 mOsm/kg), o sódio caiu de 129 para 126, com balanço positivo, ganho de peso e sem hemoconcentração. Com urina fixa em 610 mOsm/kg, o rim excreta os osmoles da salina em cerca de metade da água infundida e retém o resto como água livre (dessalinização), o que só acontece quando o ADH está alto de forma inapropriada; na perda cerebral de sal o ADH é estímulo de volume, a salina o desliga e o sódio sobe. A restrição hídrica isolada falha porque a relação (sódio + potássio urinários)/sódio plasmático é de 212/126, acima de 1, e há piora neurológica num cérebro contuso. Por isso suspende-se a isotônica e faz-se salina a 3% em bolus, depois associando restrição e ureia, com limite de correção de 8 a 10 mEq/L em 24 horas.

A) SIADH / salina a 3%, sem mais isotônica CORRETA

Correta. SIADH com urina mais concentrada que a salina e piora neurológica: salina hipertônica, retirando a isotônica que agrava a hiponatremia.

B) Perda cerebral de sal / mais salina a 0,9% ARMADILHA

Errada. Seria a conduta na perda cerebral de sal, com balanço negativo, perda de peso e hemoconcentração, em que a salina sobe o sódio; aqui ele caiu com ela.

C) SIADH / restrição hídrica isolada

Errada. O diagnóstico está certo, mas com relação eletrolítica urina/plasma acima de 1 a restrição isolada falha, e há sintomas que pedem correção mais rápida.

D) Perda cerebral de sal / fludrocortisona

Errada. Fludrocortisona é adjuvante na perda cerebral de sal hipovolêmica, que não é o caso, e retém mais sódio sem tratar a água livre.

Para levar. Salina a 0,9% piora o sódio sempre que a osmolalidade urinária passa de cerca de 300 mOsm/kg com ADH inapropriado; queda do sódio com salina e balanço positivo afasta perda cerebral de sal e pede salina a 3%.

European Clinical Practice Guideline on Diagnosis and Treatment of Hyponatraemia (ESE/ESICM/ERBP, 2014); Verbalis et al., Am J Med 2013.

8

Neurologia · Flexão tripla durante o protocolo de morte encefálica: reflexo medular, e o protocolo segue para o teste de apneia

Negativo no meio

Gabarito B

Mulher de 38 anos, com hemorragia subaracnóidea aneurismática e herniação documentada em TC, está em ventilação mecânica há 30 horas, sem sedativo há 26 horas (midazolam em infusão apenas nas 4 primeiras horas, função renal e hepática normais). Temperatura esofágica 36,4 °C, PAM 78 mmHg com noradrenalina em dose baixa, SatO2 98%, sódio 152 mEq/L, glicemia 164 mg/dL. Foi aberto o protocolo de morte encefálica: no primeiro exame clínico, coma aperceptivo, pupilas médias e fixas, ausência dos reflexos fotomotor, corneopalpebral, oculocefálico, vestibulocalórico e de tosse. Ao estímulo doloroso no leito ungueal do hálux, observa-se flexão tripla do membro inferior estimulado, com sudorese no tronco; o estímulo supraorbitário não provoca resposta. A família foi informada pela enfermagem de que 'ela mexeu a perna'. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

o estímulo supraorbitário não provoca resposta

Resolução. O movimento da perna parece negar a morte encefálica e leva a interromper o protocolo. Mas o que importa é de onde vem a resposta: estímulo no território medular (hálux) gerando flexão tripla e sudorese é arco reflexo medular e autonômico, que sobrevive à morte do encéfalo; o estímulo no território do trigêmeo (supraorbitário), que testa o tronco, não gera nada. O manual que acompanha a Resolução CFM 2.173/2017 lista os sinais de reatividade infraespinal (reflexos osteotendinosos, cutâneo-plantar, flexores de retirada, arrepio, entre outros) como achados que não invalidam o diagnóstico; o que a resolução exige é coma não perceptivo e ausência de reatividade supraespinal. Os pré-requisitos estão cumpridos: lesão estrutural conhecida, mais de 6 horas de tratamento e observação, sedativo suspenso há tempo suficiente, temperatura acima de 35 °C, PAM de pelo menos 65 mmHg e SatO2 acima de 94%; um sódio de 152, comum na morte encefálica por diabetes insípido, não explica o coma de uma herniação documentada. O passo seguinte é o teste de apneia, feito uma única vez por um dos examinadores; o exame complementar é obrigatório, mas não é pré-condição para a apneia.

A) Interromper o protocolo e reavaliar em 24 horas ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Interromper seria o certo se o estímulo craniano provocasse resposta motora ou se houvesse descerebração; flexão tripla ao estímulo no pé é reflexo medular e não invalida o protocolo.

B) Prosseguir com o teste de apneia CORRETA

Correta. Pré-requisitos cumpridos e ausência de reflexos de tronco: segue-se o teste de apneia, e o movimento medular é explicado à família.

C) Corrigir o sódio antes de prosseguir
Errada. Corrigir antes seria obrigatório se um distúrbio grave pudesse, por si, explicar o coma; hipernatremia leve numa herniação documentada não é fator de confusão e não impede o protocolo.

D) Fazer eletroencefalograma antes da apneia
Errada. O exame complementar é obrigatório para concluir o diagnóstico, mas não é condição para o teste de apneia; exigi-lo antes só atrasa o protocolo.

Para levar. No protocolo de morte encefálica, resposta motora a estímulo no território medular (flexão tripla, sinal de Lázaro, sudorese) é reflexo medular e não interrompe o diagnóstico; o que importa é ausência de resposta ao estímulo craniano.

Resolução CFM nº 2.173/2017 e anexo I (Manual de Procedimentos para Determinação da Morte Encefálica); Greer DM et al. Pediatric and Adult Brain Death/Death by Neurologic Criteria Determination: AAN/AAP/CNS/SCCM consensus guideline, Neurology 2023.

9

Hematologia · Ácido tranexâmico na hemorragia digestiva alta: sem benefício em mortalidade e com mais trombose venosa

Omissão **Gabarito B**

Na hemorragia digestiva alta aguda do adulto, segundo o maior ensaio clínico randomizado sobre o tema, o ácido tranexâmico intravenoso em dose alta:

O DADO QUE DECIDE
segundo o maior ensaio clínico randomizado sobre o tema

Resolução. O benefício do ácido tranexâmico no trauma (até 3 horas) e na hemorragia pós-parto faz pensar que todo sangramento grave se beneficia dele, inclusive o digestivo, o que levaria a dá-lo na admissão. O estudo HALT-IT, com cerca de 12.000 pacientes com hemorragia digestiva, mostrou o contrário: nenhuma redução de mortalidade por sangramento, nem de ressangramento, e aumento de eventos tromboembólicos venosos e de convulsões com a dose alta. Não houve benefício em subgrupos, inclusive varicosos e com sangramento há menos de 3 horas. Por isso as diretrizes recomendam não usar ácido tranexâmico intravenoso na hemorragia digestiva alta, e a conduta continua sendo ressuscitação, inibidor de bomba ou vasoativo conforme a causa, e endoscopia em até 24 horas.

A) Está indicado se a endoscopia atrasar
Errada. O atraso da endoscopia não cria indicação; o tratamento é ressuscitação e endoscopia precoce.

B) Não reduz mortalidade e aumenta trombose CORRETA
Correta. O HALT-IT não mostrou redução de mortalidade e mostrou mais trombose venosa e convulsões.

C) Está indicado só na hemorragia varicosa
Errada. No subgrupo de hepatopatas e varicosos também não houve benefício, e o risco trombótico se manteve.

D) Deve ser dado antes da endoscopia ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Transposição do trauma e da hemorragia pós-parto, em que o fármaco reduz mortalidade se dado cedo; no sangramento digestivo, não.

Para levar. Ácido tranexâmico funciona no trauma e na hemorragia pós-parto quando dado cedo, mas não na hemorragia digestiva: lá não reduz mortalidade e aumenta trombose venosa.

HALT-IT Trial Collaborators, Lancet 2020; ESGE Guideline on non-variceal upper GI hemorrhage (2021); ACG Guideline upper GI and ulcer bleeding (2021).

---

10 Infectologia · Influenza com hipoxemia no 4º dia de sintomas: oseltamivir indicado fora da janela de 48 horas e sem esperar o RT-PCR

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 67 anos, diabética e com DPOC, procura a emergência em julho, no 4º dia de febre de 38,8 °C, mialgia intensa, cefaleia e tosse seca. Duas pessoas da casa tiveram quadro parecido na semana anterior. Exame: T 38,4 °C, FR 26 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, PA 128 × 74 mmHg, estertores finos em bases. Radiografia de tórax: infiltrado intersticial bilateral discreto. Será internada com oxigênio. O swab nasofaríngeo para RT-PCR de vírus respiratórios foi colhido, com resultado previsto em 48 horas. Quanto ao oseltamivir, a indicação e o momento de início são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Será internada com oxigênio

Resolução. A janela de 48 horas é o número que o aluno guarda, e ela empurra para negar o antiviral no 4º dia de sintomas. Ela vale para o paciente ambulatorial sem risco, em quem o benefício é encurtar sintomas. Na síndrome respiratória aguda grave (hipoxemia, internação) e em quem tem fator de risco para complicação (idade acima de 60 anos, diabetes, pneumopatia), o oseltamivir está indicado independentemente do tempo de sintomas, porque reduz mortalidade mesmo iniciado tardiamente. E deve começar na suspeita clínica, sem aguardar confirmação laboratorial: esperar 48 horas pelo RT-PCR é perder o benefício que se quer obter. A conduta é oseltamivir 75 mg de 12/12 horas por 5 dias, ajustado à função renal, associado à cobertura de pneumonia bacteriana secundária se houver suspeita.

A) Indicado / após o resultado do RT-PCR
Errada. Acerta a indicação, mas atrasa o início; o protocolo manda iniciar na suspeita de SRAG, sem esperar o resultado.

B) Não indicado / fora da janela de 48 horas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a janela de 48 horas vale para o caso leve ambulatorial, não para o paciente hipoxêmico internado ou com fator de risco.

C) Não indicado / apenas se RT-PCR positivo
Errada. Condicionar ao RT-PCR nega a indicação e ainda atrasa o tratamento de um caso grave.

D) Indicado / imediatamente, sem esperar CORRETA
Correta. Hipoxemia e internação definem SRAG, e o oseltamivir é indicado em qualquer tempo de doença, iniciado já na suspeita.

Para levar. Na influenza grave ou em quem tem fator de risco, o oseltamivir é indicado mesmo após 48 horas de sintomas e começa na suspeita clínica, sem aguardar o exame.

Ministério da Saúde, Guia de Manejo e Tratamento de Influenza (2023); IDSA Clinical Practice Guidelines on Seasonal Influenza (2018).

11

Endocrinologia · Hipoglicemias de madrugada no idoso em uso de gliclazida após antibiótico em dose única diária para pneumonia: fluoroquinolona respiratória a deduzir

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 78 anos, com diabetes tipo 2 há 15 anos em uso de metformina 1.000 mg/dia e gliclazida MR 60 mg/dia (HbA1c recente de 7,1%), hipertensão e doença renal crônica com TFGe de 38 mL/min/1,73 m², foi atendido na UPA há 4 dias por tosse produtiva, febre e consolidação em base direita, com CURB-65 de 1, e recebeu alta com um antibiótico oral em dose única diária, em monoterapia, escolhido porque ele é alérgico a penicilina. Desde ontem teve três episódios de sudorese e confusão de madrugada, com glicemias capilares de 42, 38 e 47 mg/dL, revertidos com glicose oral. Não mudou a alimentação nem as doses. Hoje: afebril, PA 132 x 78 mmHg, FC 84 bpm, SpO2 95%. Exames: creatinina 1,7 mg/dL (basal de 1,6 mg/dL), sódio 138 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, cortisol às 8 horas 19 µg/dL, ECG com QTc de 488 ms. A causa mais provável das hipoglicemias é:

O DADO QUE DECIDE

um antibiótico oral em dose única diária, em monoterapia, escolhido porque ele é alérgico a penicilina

Resolução. Idoso, renal crônico e em uso de sulfonilureia: o reflexo é culpar a gliclazida acumulada, e é a armadilha. Mas a creatinina está estável (1,7 contra 1,6 de base) e a HbA1c de 7,1% mostra anos de esquema sem hipoglicemia; o que mudou há 4 dias foi o antibiótico. Para pneumonia comunitária ambulatorial em quem tem comorbidades (diabetes, DRC) e é alérgico a penicilina, a monoterapia oral em dose única diária é a fluoroquinolona respiratória (levofloxacino ou moxifloxacino), e o QTc de 488 ms reforça a dedução. As fluoroquinolonas bloqueiam os canais de potássio dependentes de ATP da célula beta e aumentam a secreção de insulina, com risco de hipoglicemia grave sobretudo em idosos, na DRC e em associação com sulfonilureia ou insulina. O cortisol de 19 µg/dL afasta a insuficiência adrenal, e a metformina isolada não causa hipoglicemia. A conduta é trocar o antibiótico e suspender ou reduzir a gliclazida enquanto durar a interação.

A) Acúmulo da metformina pela TFG baixa
Errada. A metformina acumulada na TFG baixa ameaça com acidose láctica, não com hipoglicemia, porque não estimula a secreção de insulina.

B) Insuficiência adrenal relativa da infecção
Errada. Insuficiência adrenal na infecção daria hipotensão e hiponatremia; cortisol matinal de 19 µg/dL praticamente a exclui.

C) Fluoroquinolona somada à sulfonilureia CORRETA
Correta. Monoterapia oral diária para pneumonia em comorbido alérgico a penicilina é fluoroquinolona respiratória; ela estimula a secreção de insulina e potencializa a sulfonilureia, e o QTc longo é outro efeito da classe.

D) Acúmulo da gliclazida por piora renal ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a causa se a função renal tivesse piorado ou a dose tivesse subido; a creatinina está no basal e o esquema era o mesmo há anos sem hipoglicemia.

Para levar. Hipoglicemia nova em diabético estável pede a lista de drogas dos últimos dias: fluoroquinolonas (e claritromicina, por interação com sulfonilureia) causam hipoglicemia, principalmente em idosos e na DRC.

FDA Drug Safety Communication 2018 (fluoroquinolonas e disglicemia); Diretriz Brasileira de Pneumonia Adquirida na Comunidade (SBPT 2018); ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 6.

12

Gastroenterologia · Pancreatite com colelitíase e soro leitoso após estrogênio oral: hipertrigliceridemia como etiologia, e não litíase

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 52 anos, com diabetes tipo 2 mal controlado (HbA1c 9,1%) e obesidade, é internada com dor epigástrica em faixa há 12 horas e vômitos. Iniciou estradiol oral há 2 meses para fogachos. Não ingere álcool. PA 124×80 mmHg, FC 104 bpm. Exames: lipase 2.900 U/L (referência até 60), amilase 140 U/L (referência até 100), ALT 38 U/L, AST 40 U/L, bilirrubina 0,7 mg/dL, fosfatase alcalina normal, cálcio 8,6 mg/dL, glicemia 286 mg/dL, soro de aspecto leitoso e triglicerídeos de 2.840 mg/dL. Ultrassonografia: vesícula com múltiplos cálculos de 5 a 8 mm e colédoco de 5 mm. A etiologia mais provável da pancreatite é:

O DADO QUE DECIDE

triglicerídeos de 2.840 mg/dL

Resolução. A vesícula com cálculos pequenos é um rótulo verdadeiro: os cálculos estão lá e a litíase é a causa mais comum de pancreatite, o que faz o apressado parar no ultrassom. Mas triglicerídeos acima de 1.000 mg/dL bastam para causar pancreatite, e aqui estão perto de 3.000, com soro leitoso. O laboratório também pesa contra a litíase: ALT abaixo de 150 U/L nas primeiras 48 horas e bilirrubina normal, com colédoco fino. A amilase só discretamente elevada é outra pista, porque o soro lipêmico interfere na dosagem. O gatilho está na droga: o estrogênio oral, por passagem hepática, aumenta a síntese de VLDL e pode precipitar hipertrigliceridemia grave em quem já tem diabetes descompensado e obesidade. A consequência prática é suspender o estrogênio oral, controlar a glicemia e tratar a hipertrigliceridemia; os cálculos serão avaliados à parte.

A) Pancreatite autoimune

Errada. Pancreatite autoimune é diagnóstico de exclusão, com imagem sugestiva e IgG4; há uma causa metabólica evidente.

B) Hipertrigliceridemia CORRETA

Correta. Triglicerídeos de 2.840 mg/dL com soro leitoso, em quem iniciou estrogênio oral e tem diabetes descompensado.

C) Toxicidade pancreática direta do estrogênio

Errada. O estrogênio age elevando os triglicerídeos, não por toxicidade direta sobre o pâncreas.

D) Litíase biliar ARMADILHA

Errada. É a armadilha. Os cálculos existem, mas ALT 38 e bilirrubina normal falam contra, e triglicerídeos acima de 1.000 já são causa suficiente.

Para levar. Pancreatite com triglicerídeos acima de 1.000 mg/dL: a hipertrigliceridemia é a causa, mesmo com cálculos na vesícula; procurar o gatilho (estrogênio oral, diabetes descompensado, álcool).

ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2024); Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Hypertriglyceridemia (2012)

13

Cardiologia · Padrão de De Winter com troponina inicial normal: oclusão aguda da descendente anterior, angioplastia primária imediata

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 52 anos, tabagista e dislipidêmico, chega ao pronto-socorro com dor retroesternal opressiva, irradiada para a mandíbula, iniciada há 50 minutos, com sudorese fria. PA 148×92 mmHg, FC 94 bpm, SpO2 96%, pulmões limpos, sem sopros. ECG da chegada: ritmo sinusal, QRS estreito, infradesnivelamento ascendente do ponto J de 2 mm de V2 a V5, seguido de ondas T altas, simétricas e apiculadas nas mesmas derivações, e supradesnivelamento de 1 mm em aVR; nenhuma derivação com supradesnivelamento do ST em 2 derivações contíguas. Troponina T ultrassensível da chegada: 9 ng/L (referência até 14 ng/L). O hospital tem hemodinâmica 24 horas, com tempo previsto até a passagem do fio de 40 minutos. O plantonista registra 'SCA sem supra de ST, troponina negativa: repetir em 1 hora'. Além de AAS e anticoagulação, a conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

seguido de ondas T altas, simétricas e apiculadas nas mesmas derivações

Resolução. O rótulo do plantonista é verdadeiro ao pé da letra: não há supradesnivelamento do ST, e a troponina da chegada ainda está normal. Mas infradesnivelamento ascendente do ponto J em precordiais com ondas T altas, simétricas e apiculadas, com leve supra em aVR, é o padrão de De Winter, equivalente de oclusão aguda da descendente anterior proximal. A troponina normal aos 50 minutos de dor não tranquiliza ninguém, porque a necrose ainda não liberou marcador suficiente. A diretriz europeia de 2023 inclui esse padrão entre os que indicam oclusão coronariana aguda e pedem reperfusão imediata, como no IAM com supra; com hemodinâmica disponível em 40 minutos, a angioplastia primária é a escolha. Esperar a segunda troponina ou adiar o cateterismo para 24 horas deixa a parede anterior morrer.

A) Fibrinólise com tenecteplase

Errada. Fibrinólise seria a escolha se o tempo previsto até a angioplastia passasse de 120 minutos; com a hemodinâmica a 40 minutos, a angioplastia é superior.

B) Cateterismo nas primeiras 24 horas

Errada. Estratégia invasiva precoce em até 24 horas é para SCA sem supra de alto risco sem padrão de oclusão; o De Winter pede reperfusão imediata.

C) Troponina seriada em 1 hora ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. O algoritmo de 0 e 1 hora serve para a dor torácica com ECG sem padrão de oclusão; aqui o ECG já decide, e a troponina precoce normal é esperada nos primeiros minutos de uma oclusão.

D) Angioplastia primária imediata CORRETA

Correta. O padrão de De Winter equivale à oclusão da descendente anterior, e com sala disponível em 40 minutos a reperfusão é por angioplastia primária, sem esperar marcador.

Para levar. Infra ascendente do ponto J em V2 a V5 com T alta, simétrica e apiculada (De Winter) é oclusão da descendente anterior: tratar como IAM com supra, sem esperar troponina.

ESC 2023 Guidelines for the management of acute coronary syndromes; Diretriz da SBC sobre IAM com supradesnível do ST, 2015; de Winter RJ et al., N Engl J Med 2008

---

14 Reumatologia · Febre reumática no adulto jovem sem sopro: ecocardiograma com Doppler para cardite subclínica antes de fechar a profilaxia

Negativo no meio | Gabarito D

Homem de 24 anos, militar em alojamento coletivo, procura atendimento por dor e edema articulares há 9 dias. Três semanas antes teve faringite febril tratada apenas com sintomáticos. A dor começou no joelho direito, passou ao tornozelo esquerdo e depois ao punho direito, cada articulação melhorando em poucos dias, com alívio rápido após iniciar naproxeno. Nega uretrite, diarreia, lesões de pele e dor lombar. Exame físico: Tax 37,9 °C, FC 104 bpm, PA 122 × 70 mmHg; bulhas normofonéticas, sem sopros e sem atrito pericárdico; artrite do punho direito. Exames: VHS 84 mm/h, PCR 96 mg/L, antiestreptolisina O 820 UI/mL (VR até 200), ECG com ritmo sinusal e intervalo PR de 0,22 s. O exame mais importante para definir a conduta neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

sem sopros e sem atrito pericárdico

Resolução. Poliartrite migratória após faringite, com febre, VHS e PCR altas e antiestreptolisina O elevada, já preenche os critérios de Jones revisados em 2015 (um critério maior e dois menores com evidência de estreptococo), e por isso o apressado acha que nada mais falta. Mas a ausculta sem sopro não afasta cardite: a revisão de 2015 incorporou a cardite subclínica, isto é, a regurgitação mitral ou aórtica patológica vista só ao Doppler, como critério maior. Todo caso suspeito ou confirmado de febre reumática deve fazer ecocardiograma com Doppler. Esse exame muda tudo o que vem depois: a presença de cardite define a duração da profilaxia secundária (sem cardite, 5 anos após o surto ou até os 21 anos; com cardite, prazos muito mais longos) e o seguimento cardiológico. O PR de 0,22 s é critério menor e não substitui a avaliação valvar.

A) Nenhum exame adicional ARMADILHA

Errada. Seria verdadeira se o diagnóstico fosse o único objetivo; aqui a cardite subclínica, invisível à ausculta, muda a profilaxia e o seguimento.

B) Cultura de orofaringe

Errada. A antiestreptolisina O alta já documenta a infecção estreptocócica; a cultura de orofaringe, semanas depois, costuma ser negativa e não muda a conduta.

C) Ressonância magnética cardíaca

Errada. Pode ajudar em miocardite de outras causas, mas não é o exame recomendado para cardite reumática, que é valvar e se define ao Doppler.

D) Ecocardiograma transtorácico com Doppler CORRETA

Correta. A cardite subclínica (regurgitação patológica ao Doppler) é critério maior e define a duração da profilaxia secundária.

Para levar. Na febre reumática, sopro ausente não afasta cardite: todo caso faz ecocardiograma com Doppler, porque a cardite subclínica é critério maior e muda a duração da profilaxia.

AHA Revision of the Jones Criteria (Circulation, 2015); Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática (SBC/SBP/SBR).

---

15 Pneumologia · Derrame pleural maligno recidivante com pulmão encarcerado: cateter pleural tunelizado, e não pleurodese

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 61 anos com adenocarcinoma de mama metastático, em quimioterapia, ECOG 1, tem derrame pleural direito com citologia oncótica positiva, em terceira recidiva sintomática em 5 semanas. Na toracocentese de alívio, após retirar 1.100 mL, surgiram tosse e desconforto torácico; a manometria mostrou queda da pressão pleural de -2 para -24 cmH2O. A radiografia logo após mostra hidropneumotórax pequeno, com o pulmão sem reexpandir e pleura visceral espessada; não houve fístula, e a paciente segue estável. Expectativa de vida estimada em vários meses. A interpretação do achado e a conduta definitiva mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

queda da pressão pleural de -2 para -24 cmH2O

Resolução. O pneumotórax após a toracocentese parece complicação do procedimento, mas é ex vacuo: o pulmão revestido por pleura visceral espessada não reexpande, e a queda rápida da pressão pleural (elastância alta, queda de mais de 14,5 cmH2O por litro) confirma o pulmão encarcerado. Não precisa de dreno. O apressado identifica o encarceramento e mantém a pleurodese com talco, que é a conduta de manual do derrame maligno recidivante; mas a pleurodese depende do contato entre as pleuras visceral e parietal, e com o pulmão que não expande ela falha. Para pulmão não expansível a diretriz indica o cateter pleural de longa permanência (tunelizado), que permite drenagens domiciliares e alivia a dispneia. A pleurodese com talco seria a escolha se o pulmão reexpandisse por completo.

A) Pulmão expansível / pleurodese com talco

Errada. Pulmão expansível seria aquele que reexpande sem queda acentuada da pressão; aqui a manometria e a imagem mostram o contrário.

B) Pulmão encarcerado / pleurodese com talco ARMADILHA

Errada. O diagnóstico está certo, mas o talco precisa de aposição das pleuras; no pulmão encarcerado a pleurodese falha.

C) Pulmão expansível / cateter pleural tunelizado

Errada. O cateter seria opção também no pulmão expansível, mas a interpretação está errada: o hidropneumotórax é ex vacuo.

D) Pulmão encarcerado / cateter pleural tunelizado CORRETA

Correta. Elastância alta e pulmão que não reexpande: encarcerado, tratado com cateter pleural tunelizado.

Para levar. Derrame maligno recidivante: se o pulmão reexpande, pleurodese ou cateter; se não reexpande (encarcerado, pneumotórax ex vacuo), cateter pleural tunelizado, porque o talco não tem pleura com que colar.

BTS Guideline for Pleural Disease (2023); ATS/STS/STR Management of Malignant Pleural Effusions (2018).

---

16 Nefrologia · Hipercalcemia no idoso ex-tabagista acamado após fratura de fêmur · imobilização sobre doença de Paget, com PTHrP indetectável

Negativo no meio **Gabarito D**

Homem de 74 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há seis anos), com fosfatase alcalina entre 380 e 450 U/L (até 129) nos últimos cinco anos, nunca investigada, e queixa antiga de que os chapéus não lhe servem mais. Há três semanas sofreu fratura de colo de fêmur, operada, e desde então está restrito ao leito por delirium e dor. Agora com poliúria, constipação e piora da sonolência. Exames: cálcio total 12,9 mg/dL (albumina 3,8 g/dL), fósforo 4,3 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL (era 0,9), fosfatase alcalina 1.240 U/L, PTH 7 pg/mL (15 a 65), PTHrP indetectável, 25-hidroxivitamina D 31 ng/mL, 1,25-di-hidroxivitamina D 18 pg/mL (18 a 72), eletroforese de proteínas e cadeias leves livres normais. Radiografia de tórax sem nódulos. Cintilografia óssea: captação intensa e homogênea em toda a hemipelve direita e na calota craniana, sem outros focos. A causa mais provável da hipercalcemia é:

O DADO QUE DECIDE

PTHrP indetectável

Resolução. O tabagismo de 45 maços-ano é verdadeiro e puxa para a hipercalcemia humoral do carcinoma escamoso, mas o PTHrP indetectável, no meio da lista, derruba essa hipótese. O PTH suprimido afasta hiperparatireoidismo, a 1,25-di-hidroxivitamina D no limite inferior afasta produção extrarrenal de calcitriol, e eletroforese e cadeias leves normais afastam mieloma. Sobra o osso: fosfatase alcalina alta há anos, crescimento do crânio e captação homogênea de um osso inteiro (hemipelve e calota) são doença de Paget poliostótica, e não metástases, que dão focos múltiplos e irregulares. O Paget raramente eleva o cálcio sozinho; a hipercalcemia aparece quando um osso de alta remodelação perde a carga mecânica, e a reabsorção segue sem formação correspondente. O tratamento é hidratação, bisfosfonato intravenoso (que também trata o Paget) e mobilização precoce.

A) Metástases ósseas de carcinoma de pulmão
Errada. Metástases dariam captação focal múltipla e irregular; aqui a captação é homogênea em ossos inteiros, com radiografia de tórax sem nódulos.

B) Hiperparatireoidismo primário
Errada. Hiperparatireoidismo primário teria PTH alto ou inapropriadamente normal; PTH de 7 pg/mL indica supressão pela hipercalcemia.

C) Hipercalcemia humoral por carcinoma escamoso ARMADILHA
Errada. É a isca do tabagismo; sem PTHrP não há mecanismo humoral, e não há tumor demonstrado.

D) Imobilização sobre doença de Paget CORRETA
Correta. Paget poliostótico com imobilização súbita, com PTH, PTHrP e calcitriol suprimidos ou baixos.

Para levar. Hipercalcemia com PTH e PTHrP suprimidos no paciente acamado deve fazer pensar em imobilização, sobretudo sobre osso de alta remodelação (Paget, adolescente, hipertireoidismo).

Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Paget's Disease of Bone (2014); Endocrine Society guideline on hypercalcemia of malignancy (2023).

---

17 Hepatologia · Síndrome de Budd-Chiari sem insuficiência hepática: anticoagulação plena como primeiro passo da estratégia escalonada

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 29 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado há 3 anos, tem há 3 semanas dor em hipocôndrio direito e aumento do volume abdominal. Nega etilismo. Exame: PA 112×70 mmHg, jugulares não túrgidas, hepatomegalia dolorosa, ascite moderada, sem encefalopatia ou asterixe. Exames: ALT 310 U/L, AST 280 U/L, bilirrubina 2,1 mg/dL, INR 1,4, albumina 3,2 g/dL, plaquetas 310.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL. Líquido ascítico com gradiente soro-ascite de 1,6 g/dL e proteína de 3,4 g/dL. Doppler: trombos oclusivos nas veias hepáticas média e direita, fluxo reduzido na esquerda, veia porta pérvia e veia cava sem estenose segmentar. Foram colhidas pesquisa de JAK2 e de trombofilias. Além de suspender o anticoncepcional, a conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ALT 310 U/L, AST 280 U/L, bilirrubina 2,1 mg/dL, INR 1,4

Resolução. O diagnóstico já veio pronto pelo Doppler, e a tentação é pular para o procedimento que descomprime o fígado, o TIPS. Mas o tratamento da síndrome de Budd-Chiari é escalonado: todos recebem anticoagulação plena imediata, com heparina e depois anticoagulante oral por tempo indeterminado, junto com o tratamento da causa e da ascite. Só quem tem estenose curta das veias hepáticas ou da cava vai para angioplastia; quem não melhora com anticoagulação, ou piora, vai para TIPS; e o transplante fica para a forma fulminante ou a falha do TIPS. Esta paciente não tem insuficiência hepática aguda (sem encefalopatia, INR 1,4), não tem estenose segmentar a dilatar, e deve começar pelo primeiro degrau. A trombólise sistêmica tem risco hemorrágico alto e papel restrito a casos selecionados de trombose recente, por via local.

A) Avaliação para transplante hepático
Errada. Transplante é para a forma fulminante ou a falha do TIPS; INR 1,4 sem encefalopatia não é insuficiência hepática aguda.

B) Trombólise sistêmica
Errada. Trombólise sistêmica não é conduta inicial; o risco de sangramento supera o benefício, e a trombólise local é exceção em centro especializado.

C) Anticoagulação plena imediata CORRETA
Correta. Toda Budd-Chiari começa com anticoagulação plena e tratamento da causa; função hepática preservada permite seguir a estratégia escalonada.

D) TIPS de urgência ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o TIPS é o degrau para quem não responde à anticoagulação e à angioplastia, não o primeiro passo em paciente sem insuficiência hepática.

Para levar. Budd-Chiari: anticoagular todos de imediato; angioplastia se estenose curta, TIPS se falha, transplante se fulminante ou falha do TIPS.

EASL Clinical Practice Guidelines: Vascular diseases of the liver (2016); AASLD Practice Guidance: Vascular liver disorders, portal vein thrombosis and procedural bleeding (2020); Baveno VII (2022)

---

18 Infectologia · Acidente elapídico com ptose identificado pelo vizinho como coral-falsa: soro antielapídico sem esperar piora

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 28 anos, jardineiro em Petrópolis, foi picado na mão direita há 2 horas por uma serpente pequena, de anéis vermelhos, pretos e brancos, ao remexer folhas. O vizinho, que mora na roça há 40 anos, matou o animal e garantiu que era coral-falsa, porque "os anéis não fecham na barriga". O paciente refere apenas parestesia discreta no local. Exame: PA 126 × 80 mmHg, FC 84 bpm, FR 18 irpm, SpO2 97%. Na mão, duas pequenas marcas puntiformes, sem edema, sem equimose e sem bolhas. Ao exame neurológico, ptose palpebral bilateral, que ele atribui ao sono, e queixa de visão turva para longe; força nos membros preservada. Tempo de coagulação normal. Não há serviço de herpetologia para identificar o animal. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

ptose palpebral bilateral

Resolução. A identificação leiga pelos anéis incompletos no ventre é verdadeira para muitas corais-falsas, e a ausência de quadro local reforça a ideia de acidente sem veneno, o que puxa para a observação. Mas o que define o acidente elapídico é a clínica, e não a identificação do animal: ptose palpebral bilateral e turvação visual em menos de 2 horas são a fácies miastênica da neurotoxina pós-sináptica (e pré-sináptica, em algumas espécies) das corais verdadeiras. O Ministério da Saúde considera todo acidente elapídico com manifestação neurológica potencialmente grave, pelo risco de insuficiência respiratória aguda por paralisia diafragmática, e indica soro antielapídico 10 ampolas IV, em dose única, independentemente do peso. A neostigmina (precedida de atropina) é adjuvante útil quando o veneno é pós-sináptico, mas não substitui o soro. O soro antibotrópico-crotálico não neutraliza o veneno elapídico, e o quadro neurológico crotálico vem com mialgia e urina escura, ausentes aqui.

A) Soro antielapídico, 10 ampolas IV CORRETA
Correta. Ptose bilateral após picada por serpente anelada é acidente elapídico até prova em contrário, e o soro antielapídico em dose única de 10 ampolas está indicado mesmo sem quadro local.

B) Observação por 24 horas, sem soro ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta numa picada por coral-falsa sem nenhum sinal sistêmico, mas a ptose bilateral já é envenenamento neurotóxico.

C) Neostigmina isolada, sem soro
Errada. A neostigmina com atropina é adjuvante no veneno pós-sináptico e pode ponte até o soro, mas usada isolada deixa o veneno circulante sem neutralização.

D) Soro antibotrópico-crotálico IV
Errada. Seria a escolha no acidente crotálico com fácies miastênica, mialgia e mioglobinúria, quando a serpente tem guizo; não neutraliza o veneno elapídico.

Para levar. No acidente por serpente anelada, a clínica neurológica manda, e não a identificação do animal: ptose ou diplopia indicam soro antielapídico 10 ampolas, sem esperar insuficiência respiratória.

Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2023), capítulo de acidentes por animais peçonhentos; Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos (MS/FUNASA).

19

Neurologia · CADASIL rotulada como desmielinizante na migranosa com aura: polos temporais anteriores e história familiar mandam para o NOTCH3, não para as microbolhas

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Mulher de 44 anos, professora, é encaminhada ao ambulatório de neurologia com laudo de 'provável doença desmielinizante'. Tem migrânea com aura visual desde os 25 anos e, nos últimos 2 anos, teve dois episódios de hemiparesia direita leve com recuperação em semanas, além de depressão em uso de sertralina. Nega tabagismo; PA 122/78 mmHg, LDL 98 mg/dL, glicemia normal. O pai teve 'derrames de repetição' a partir dos 48 anos e morreu com demência aos 59; um tio paterno teve quadro semelhante. Exame: leve hiper-reflexia à direita, sem outros achados. RM de encéfalo: hiperintensidades confluentes em T2/FLAIR na substância branca periventricular, nas cápsulas externas e nos polos temporais anteriores, com infartos lacunares antigos e micro-hemorragias, sem realce pelo gadolínio. Líquor sem bandas oligoclonais. Ecocardiograma transtorácico e angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos normais. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

nas cápsulas externas e nos polos temporais anteriores

Resolução. Mulher jovem, sem fatores de risco vasculares, com migrânea com aura e infartos: o reflexo é procurar forame oval patente, e a armadilha é o transesofágico com microbolhas. Só que os infartos aqui são lacunares, de pequenos vasos, e não corticais embólicos, e vêm acompanhados de leucoencefalopatia confluente, micro-hemorragias, depressão e uma história paterna de AVC de repetição e demência antes dos 60 anos. O dado que fecha é a topografia: hiperintensidade nos polos temporais anteriores e nas cápsulas externas é o marcador de imagem da CADASIL e não aparece na doença de pequenos vasos hipertensiva nem na esclerose múltipla (sem realce e sem bandas oligoclonais). O exame que confirma é o genético, com pesquisa de variante patogênica no NOTCH3 (a biópsia de pele com depósitos osmiofílicos granulares é a alternativa quando o genético não decide). Forame oval não explica lacunas nem leucoencefalopatia confluente, e a angiografia digital não acrescenta nada a uma angiotomografia normal numa arteriopatia de pequenos vasos.

A) Anticorpo anti-aquaporina-4 sérico
Errada. Anti-aquaporina-4 seria o exame na mielite longitudinal extensa ou na neurite óptica grave; aqui não há medula nem nervo óptico, e o padrão de imagem é vascular.

B) Ecocardiograma transesofágico com microbolhas ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Microbolhas seriam o exame no infarto cortical embólico de causa indeterminada no jovem; lacunas com leucoencefalopatia confluente e história familiar não se explicam por embolia paradoxal.

C) Pesquisa de variante patogênica no NOTCH3 CORRETA
Correta. Polos temporais anteriores e cápsulas externas acometidos, lacunas, migrânea com aura e herança autossômica dominante apontam CADASIL, confirmada pelo NOTCH3.

D) Angiografia cerebral digital
Errada. Angiografia digital caberia na suspeita de vasculite primária do SNC ou de vasoconstrição; a doença aqui é de arteríolas que a angiografia não mostra.

Para levar. Lacunas e leucoencefalopatia confluente no adulto jovem sem fatores de risco, com migrânea com aura e história familiar: pense em CADASIL; o polo temporal anterior acometido é o dado de imagem, e o NOTCH3 confirma.

Mancuso M et al. Monogenic cerebral small-vessel diseases: diagnosis and therapy. Consensus recommendations of the European Academy of Neurology. Eur J Neurol 2020; AHA/ASA 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and TIA.

---

20 Hematologia · Massa ileocecal em jovem sem HIV com Ki-67 de 99% e BCL2 negativo: linfoma de Burkitt e o rearranjo de MYC

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 31 anos, HIV negativo, sem comorbidades, procura atendimento por dor em fossa ilíaca direita e aumento do volume abdominal há 3 semanas. TC de abdome: massa ileocecal de 11 cm, com ascite moderada. Exames: LDH 2.900 U/L, ácido úrico 9,8 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL, potássio 5,1 mEq/L. Biópsia da massa: infiltração difusa por células de tamanho médio e monomórficas, com numerosos macrófagos de citoplasma claro entremeados. Imuno-histoquímica: CD20+, CD10+, BCL6+, BCL2 negativo, TdT negativo, Ki-67 de 99%. A alteração genética esperada neste tumor é:

O DADO QUE DECIDE

BCL2 negativo

Resolução. Massa abdominal volumosa de células B CD20+ e CD10+ com LDH alta puxa para linfoma difuso de grandes células B, e daí para a t(14;18) do BCL2, que muitos associam a linfoma B de centro germinativo. Mas o painel traz o negativo que decide: BCL2 negativo, com células médias monomórficas, macrófagos de corpos tingíveis (o aspecto em céu estrelado) e Ki-67 próximo de 100%. Esse conjunto é do linfoma de Burkitt, cuja lesão definidora é a translocação de MYC, em geral t(8;14) com o locus da cadeia pesada (ou as variantes t(2;8) e t(8;22)). A forma esporádica, fora do HIV, acomete jovens com massa ileocecal e tem altíssimo risco de lise tumoral, já sugerido pelo ácido úrico e pelo potássio. TdT negativo afasta linfoma linfoblástico, e BCR-ABL1 é próprio de LMC e de parte das LLA.

A) Rearranjo de MYC, t(8;14) CORRETA
Correta. Células médias, céu estrelado, CD10+, BCL2 negativo e Ki-67 de 99%: linfoma de Burkitt, com rearranjo de MYC.

B) Rearranjo de BCL2, t(14;18) ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A t(14;18) é do linfoma folicular e de parte dos difusos de grandes células, que expressam BCL2; aqui o BCL2 é negativo.

C) Rearranjo de CCND1, t(11;14)
Errada. A t(11;14) com ciclina D1 define o linfoma do manto, CD5+ e CD10 negativo.

D) Fusão BCR-ABL1, t(9;22)
Errada. BCR-ABL1 é da LMC e da LLA Ph+, com blastos TdT+; aqui o TdT é negativo.

Para levar. Linfoma B CD10+ com BCL2 negativo, céu estrelado e Ki-67 perto de 100% é Burkitt: rearranjo de MYC, risco máximo de lise tumoral, inclusive fora do HIV.

Classificação OMS de neoplasias hematolinfoides, 5ª edição (2022); NCCN Guidelines B-cell Lymphomas (2025).

21

Endocrinologia · Diabetes rotulado como tipo 1 com peptídeo C preservado após 9 anos e variante no HNF1A: gliclazida em dose baixa no lugar da insulina

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Mulher de 26 anos tem diagnóstico de diabetes tipo 1 desde os 17 anos, feito por glicemia de 290 mg/dL sem cetoacidose, e usa insulina glargina 10 U/dia e asparte 3 a 4 U por refeição. Relata hipoglicemias frequentes mesmo com essas doses e HbA1c de 7,9%. A mãe teve diabetes aos 22 anos, tratada por muitos anos só com glibenclamida, e o avô materno também era diabético; nenhum deles é obeso. IMC 21 kg/m², sem acantose. Exames: anti-GAD, anti-IA2 e anti-ZnT8 negativos; peptídeo C de 1,8 ng/mL com glicemia simultânea de 160 mg/dL; glicosúria 3+ com glicemia de 140 mg/dL; PCR ultrassensível de 0,2 mg/L. O sequenciamento genético mostrou variante patogênica no gene HNF1A. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

variante patogênica no gene HNF1A

Resolução. O rótulo de diabetes tipo 1 é antigo e parece sólido (jovem, magra, diagnóstico aos 17 anos), e por isso o apressado só ajusta a insulina. Mas nove anos depois o peptídeo C segue preservado, os três autoanticorpos são negativos, há herança autossômica dominante em três gerações e a mãe foi controlada anos com sulfonilureia: é diabetes monogênico, confirmado pela variante no HNF1A (MODY 3). Nesse tipo, a célula beta responde de forma exagerada às sulfonilureias, que costumam controlar a glicemia melhor que a insulina e em doses baixas (gliclazida 20 a 40 mg ou glibenclamida 1,25 a 2,5 mg), com troca gradual e vigilância de hipoglicemia. A glicosúria com glicemia de 140 mg/dL (limiar renal baixo, defeito tubular do HNF1A) e a PCR ultrassensível muito baixa são marcas do mesmo gene. A metformina não aproveita a sensibilidade específica que define o tratamento.

A) Gliclazida em dose baixa, suspendendo a insulina CORRETA

Correta. MODY por HNF1A é muito sensível a sulfonilureia: dose baixa de gliclazida substitui a insulina, com titulação lenta para evitar hipoglicemia.

B) Insulina basal isolada, sem os bolus

Errada. Simplificar a insulina seria opção no tipo 2 ou no autoimune latente com secreção residual; não usa a resposta específica à sulfonilureia.

C) Manter o basal-bolus com doses menores ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria o ajuste no tipo 1 com hipoglicemias; aqui o rótulo caiu com o peptídeo C preservado, autoanticorpos negativos e a variante no HNF1A.

D) Metformina, suspendendo a insulina

Errada. Metformina é a primeira linha no tipo 2 com resistência à insulina; no HNF1A o defeito é de secreção, e a resposta é muito inferior à da sulfonilureia.

Para levar. Diabetes jovem, não obeso, com autoanticorpos negativos, peptídeo C preservado anos depois e herança em três gerações: pense em MODY. HNF1A e HNF4A tratam com sulfonilureia em dose baixa; glicoquinase não trata.

ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 2; ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022 (diabetes monogênico); Diretriz SBD 2024.

---

22 Cardiologia · Ehlers-Danlos vascular no puerpério: rotura de artéria visceral de médio calibre, confirmada por angiotomografia e não por arteriografia

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 31 anos, no 9º dia após parto vaginal sem intercorrências, chega ao pronto-socorro com dor súbita em hipocôndrio esquerdo e ombro esquerdo há 3 horas, com sudorese e tontura. Antecedentes: perfuração espontânea do sigmoide aos 24 anos, pneumotórax espontâneo aos 19, equimoses fáceis desde a infância e pé torto congênito; a mãe morreu aos 38 anos de 'hemorragia interna sem causa'. Ao exame: 1,61 m, envergadura igual à altura, face magra com nariz afilado e lábios finos, pele fina e translúcida, com a rede venosa visível no tórax e no abdome; pele sem hiperextensibilidade e grandes articulações com mobilidade normal; exame oftalmológico na gestação sem subluxação do cristalino. PA 90×56 mmHg e FC 120 bpm na chegada; após 1 litro de cristaloide e 2 concentrados de hemácias, PA 108×66 mmHg e FC 102 bpm. Hb 7,9 g/dL. Ultrassonografia à beira do leito: líquido livre perisplênico e na pelve; ecocardiograma focado com raiz aórtica de 31 mm e sem derrame pericárdico. A lesão vascular mais provável e o exame de imagem mais adequado para confirmá-la são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pele fina e translúcida, com a rede venosa visível no tórax e no abdome

Resolução. Colapso hemorrágico em jovem com doença do tecido conjuntivo puxa o reflexo do Marfan, e a dissecção da aorta é a isca. Mas o fenótipo aqui é outro: pele fina e translúcida com veias visíveis, face magra com nariz afilado e lábios finos, equimoses fáceis, perfuração espontânea de cólon, pneumotórax e morte súbita hemorrágica da mãe compõem a síndrome de Ehlers-Danlos vascular (tipo IV, mutação do COL3A1, autossômica dominante). Nela a artéria rompe ou disseca sem dilatação prévia, e os vasos mais atingidos são os de médio calibre (esplênica, renais, ilíacas, mesentéricas); a gestação e o puerpério são o período de maior risco. A raiz de 31 mm, a envergadura igual à altura e o cristalino normal afastam o Marfan, e o líquido perisplênico localiza o sangramento. Quanto ao exame, com a paciente respondendo à reposição há tempo para imagem: na forma vascular a arteriografia por cateter tem alta taxa de rotura e dissecção no próprio sítio de punção, e a confirmação deve ser não invasiva, por angiotomografia (ou angiorressonância); o cateter fica reservado para a embolização terapêutica quando ela for inevitável.

A) Dissecção aórtica por dilatação da raiz / angiotomografia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta no Marfan, com raiz dilatada, envergadura maior que a altura e subluxação do cristalino; aqui a raiz mede 31 mm e o sangue está ao redor do baço, não no mediastino ou no pericárdio.

B) Rotura de artéria visceral de médio calibre / arteriografia por cateter
Errada. A lesão está certa, mas a arteriografia diagnóstica por cateter é evitada no Ehlers-Danlos vascular pelo risco de rotura e dissecção iatrogênicas; seria aceitável num aneurisma visceral sem doença do colágeno.

C) Rotura de artéria visceral de médio calibre / angiotomografia CORRETA

Correta. Pele translúcida com veias visíveis, perfuração de cólon e morte hemorrágica materna definem a forma vascular, que rompe artérias de médio calibre; a confirmação é por imagem não invasiva.

D) Dissecção aórtica por dilatação da raiz / arteriografia por cateter

Errada nas duas metades: a raiz normal afasta a dissecção por dilatação, e a arteriografia por cateter é o exame a evitar nesta síndrome.

Para levar. Ehlers-Danlos vascular (pele translúcida, equimoses, perfuração de víscera oca, morte súbita familiar): rotura de artéria de médio calibre sem dilatação prévia, pior na gestação; confirme com angiotomografia e evite arteriografia diagnóstica.

Byers PH et al., GeneReviews: Vascular Ehlers-Danlos Syndrome (atualização 2023); ESC 2024 Guidelines for peripheral arterial and aortic diseases (síndromes aórticas e arteriais hereditárias); International EDS Consortium 2017

23

Reumatologia · Febre familiar do Mediterrâneo: colchicina contínua, e não só nas crises, porque o que ela previne é a amiloidose AA

Grade X / Y **Gabarito A**

Na febre familiar do Mediterrâneo, o tratamento de base e a complicação a longo prazo que ele previne são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

o tratamento de base e a complicação a longo prazo que ele previne

Resolução. As crises da febre familiar do Mediterrâneo duram de 1 a 3 dias e cedem sozinhas, o que leva a pensar em tratar só os episódios. Mas a inflamação subclínica persiste entre as crises, com proteína amiloide A sérica elevada, e é ela que produz a complicação grave: a amiloidose AA, sobretudo renal, com síndrome nefrótica e doença renal crônica. Por isso, a recomendação da EULAR é colchicina diária e contínua, por toda a vida, desde o diagnóstico, ajustada para controlar crises e marcadores inflamatórios; anti-IL-1 entra na resistência ou intolerância. A amiloidose AL é a das discrasias de plasmócitos, e o corticoide não tem papel no tratamento de base.

A) Colchicina contínua / amiloidose AA CORRETA

Correta. Colchicina diária e contínua previne as crises e, principalmente, a amiloidose AA.

B) Colchicina contínua / amiloidose AL

Errada. A colchicina contínua está certa, mas a amiloidose da doença inflamatória crônica é AA; a AL é da discrasia de plasmócitos.

C) Colchicina nas crises / amiloidose AA ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria aceitável se o problema fossem só as crises, que são autolimitadas; a inflamação entre elas continua e é a que causa amiloidose AA.

D) Prednisona nas crises / amiloidose AA

Errada. O corticoide não previne crises nem amiloidose na febre familiar do Mediterrâneo; a resistência à colchicina se trata com anti-IL-1.

Para levar. Na febre familiar do Mediterrâneo, colchicina todos os dias e para sempre: o alvo não é a crise, é a amiloidose AA renal.

EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever (Ozen et al., Ann Rheum Dis 2016).

---

24 Pneumologia · Tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa em amostra salivar: escarro induzido antes da broncoscopia

Omissão **Gabarito C**

Homem de 58 anos, diabético em uso de metformina, tem tosse seca há 7 semanas, febre vespertina e perda de 6 kg. Anti-HIV não reagente. Radiografia de tórax: opacidade heterogênea no ápice direito com pequena cavidade. Uma amostra de escarro colhida na primeira consulta, de pouco volume e aspecto salivar, teve baciloscopia negativa; desde então ele não consegue expectorar, apesar de orientado. TC de tórax: cavidade de 2 cm e nódulos centrolobulares em árvore em brotamento no lobo superior direito. SpO2 96% em ar ambiente, sem hemoptise. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

de pouco volume e aspecto salivar

Resolução. O quadro clínico e tomográfico é de tuberculose pulmonar ativa até prova em contrário, e a única baciloscopia negativa não afasta nada: a amostra era salivar, inadequada. Quem não expectora e tem baciloscopia negativa cai na tentação de pular para a broncoscopia, que é o exame de maior porte e o que o apressado marca. A ordem recomendada pelo Ministério da Saúde é obter escarro de boa qualidade, e quando o paciente não expectora, o escarro induzido com salina hipertônica tem rendimento semelhante ao do lavado broncoalveolar, sem procedimento invasivo. Na amostra induzida se pede o teste rápido molecular (que também mostra resistência à rifampicina) e a cultura com teste de sensibilidade. A broncoscopia fica para quem segue sem diagnóstico depois do escarro induzido. Prova tuberculínica não diagnostica doença ativa.

A) Broncoscopia com lavado broncoalveolar ARMADILHA
Errada. Seria o passo seguinte se o escarro induzido também fosse negativo ou impossível; aqui ainda não se tentou a amostra adequada.

B) Prova tuberculínica
Errada. Positiva indica infecção, não doença ativa; negativa não exclui tuberculose em quem está doente.

C) Escarro induzido para TRM-TB e cultura CORRETA
Correta. A única amostra foi salivar e ele não expectora: escarro induzido com TRM-TB e cultura é o degrau certo antes da broncoscopia.

D) Biópsia transbrônquica
Errada. Procedimento invasivo de maior risco, indicado em suspeita de doença intersticial ou neoplasia sem diagnóstico, não como segundo passo na tuberculose.

Para levar. Baciloscopia negativa em amostra ruim não é baciloscopia negativa. Sem expectoração, escarro induzido (TRM-TB e cultura) vem antes da broncoscopia.

Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª ed. atualizada (2019); OMS, Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 3: Diagnosis (2024).

---

25 Oncologia · Degeneração cerebelar paraneoplásica anti-Yo após ressecção do tumor: déficit persistente, porque a perda de células de Purkinje é precoce e irreversível

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 58 anos desenvolveu, em 6 semanas, ataxia de marcha e de membros, disartria e nistagmo, até ficar restrita à cadeira de rodas. Ressonância de crânio normal; líquor com 12 linfócitos/mm³ e bandas oligoclonais; anticorpo anti-Yo (anti-PCA1) fortemente positivo. A investigação achou carcinoma seroso de ovário em estádio inicial, ressecado com margens livres, seguido de quimioterapia adjuvante; recebeu também metilprednisolona e imunoglobulina intravenosa. Três meses depois, CA-125 normalizado e sem doença residual na imagem. Em relação ao quadro neurológico, a evolução mais esperada é:

O DADO QUE DECIDE

em 6 semanas

Resolução. A lógica de que tratar o tumor cura a síndrome paraneoplásica atrai para a recuperação completa. Ela vale para síndromes mediadas por anticorpos contra antígenos de superfície (como Lambert-Eaton e encefalite anti-NMDA), em que o anticorpo é o efetor e a função volta. O anti-Yo é dirigido contra antígeno intracelular das células de Purkinje: o anticorpo é marcador, e a lesão é feita por linfócitos T citotóxicos, que destroem as células de Purkinje em poucas semanas. Quando o quadro se instala em 6 semanas até a cadeira de rodas, o substrato neuronal já se perdeu, e o tratamento do tumor e a imunoterapia, no melhor cenário, estabilizam o déficit. A queda do marcador tumoral mostra controle oncológico, não recuperação neurológica. Por isso a urgência é achar e tratar o tumor cedo, antes que a perda se complete.

A) Melhora paralela à queda do CA-125
Errada. O CA-125 mede o tumor; a perda de células de Purkinje não acompanha a resposta oncológica.

B) Surtos com remissão completa entre eles
Errada. Curso em surtos e remissões não é o da degeneração cerebelar paraneoplásica, que é subaguda e monofásica.

C) Estabilização com déficit grave persistente CORRETA
Correta. Anticorpo contra antígeno intracelular e lesão por linfócitos T: perda precoce de Purkinje e déficit que, no máximo, estabiliza.

D) Recuperação completa com a ressecção do tumor ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a recuperação após tratar o tumor ocorre nas síndromes por anticorpo contra antígeno de superfície, não no anti-Yo.

Para levar. Síndromes paraneoplásicas com anticorpo contra antígeno intracelular (anti-Yo, anti-Hu) deixam déficit fixo; tratar o tumor cedo estabiliza, raramente recupera.

Graus F et al. Updated diagnostic criteria for paraneoplastic neurologic syndromes. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm (2021); Dalmau J, Rosenfeld MR. Paraneoplastic syndromes of the CNS. Lancet Neurol (2008)

---

26 Infectologia · Lesões cerebrais com realce anelar na aids e PCR de EBV positiva no líquor: resposta radiológica ao tratamento empírico define toxoplasmose

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 36 anos, com aids diagnosticada há 1 mês (CD4 38 células/mm³, ainda sem TARV), apresentou cefaleia, febre baixa e hemiparesia direita progressivas em 10 dias. RM de crânio: três lesões com realce anelar e edema perilesional, em núcleos da base e na junção córtico-subcortical, sem contato com o epêndima. IgG anti-Toxoplasma reagente. Iniciados sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Uma punção lombar, feita após a imagem por não haver desvio de linha média, mostrou 12 células/mm³, proteína de 68 mg/dL, PCR para Toxoplasma gondii negativa e PCR para vírus Epstein-Barr positiva. No 14º dia de tratamento, a hemiparesia regrediu quase por completo, e a nova RM mostra redução de mais de 50% do volume das lesões. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

redução de mais de 50% do volume das lesões

Resolução. A PCR de EBV positiva no líquor é um rótulo verdadeiro e forte: na pessoa com aids e lesão expansiva, ela aumenta muito a probabilidade de linfoma primário do SNC e, quando o tratamento empírico falha, apoia a biópsia. Mas o teste tem falsos positivos (o EBV pode ser detectado no líquor em outras inflamações do SNC), e a PCR de toxoplasma no líquor tem sensibilidade baixa, de modo que um resultado negativo não exclui toxoplasmose. O que decide aqui é a prova terapêutica, que é o próprio critério diagnóstico na prática: lesões múltiplas, em núcleos da base e junção córtico-subcortical, com IgG reagente e resposta clínica e radiológica nítida em 10 a 14 dias de esquema específico, são neurotoxoplasmose. O linfoma não regride com sulfadiazina e pirimetamina; regride com corticoide, que este paciente não recebeu. A conduta é manter o tratamento e iniciar a TARV em cerca de 2 semanas, sem biópsia.

A) Linfoma primário do SNC ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria o diagnóstico com lesão única periventricular ou subependimária, sem resposta ao tratamento empírico em 14 dias e PCR de EBV positiva.

B) Neurotoxoplasmose CORRETA
Correta. Lesões múltiplas em núcleos da base, IgG reagente e regressão de mais de 50% em 14 dias de esquema específico, sem corticoide, confirmam toxoplasmose.

C) Linfoma e toxoplasmose concomitantes
Errada. A coexistência existe, mas exigiria lesão que não responde ao tratamento enquanto as outras regridem; aqui todas regrediram.

D) Leucoencefalopatia multifocal progressiva
Errada. A LEMP dá lesões de substância branca sem realce e sem efeito de massa, com PCR para vírus JC no líquor.

Para levar. Na lesão expansiva cerebral da aids, a resposta clínica e radiológica ao tratamento empírico para toxoplasma em 14 dias vale mais do que uma PCR de EBV positiva isolada no líquor.

Ministério da Saúde, PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, módulo 2 (2023); NIH/CDC/IDSA Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults with HIV (atualização 2024).

---

27 Hematologia · Transfusão maciça com choque persistente e QT longo: hipocalcemia pelo citrato, e não falta de plasma

Negativo no meio — Gabarito C

Homem de 58 anos, etilista, com hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal, chega em choque. Nas primeiras 3 horas recebe, pelo protocolo de transfusão maciça, 10 unidades de concentrado de hemácias, 8 de plasma fresco congelado e 1 dose de plaquetas, além de pantoprazol, e aguarda a endoscopia. Apesar disso, mantém PA 82 × 48 mmHg e FC 118 bpm, com noradrenalina em dose crescente, extremidades frias e QTc de 520 ms no monitor. Não há saída de sangue pela sonda nasogástrica nos últimos 40 minutos. Exames colhidos agora: Hb 8,9 g/dL, plaquetas 92.000/mm³, INR 1,4, fibrinogênio 190 mg/dL, lactato 4,1 mmol/L, potássio 4,6 mEq/L, cálcio iônico 0,78 mmol/L (VR 1,12 a 1,32), temperatura 35,4 °C. Além do aquecimento ativo, a medida mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

cálcio iônico 0,78 mmol/L (VR 1,12 a 1,32)

Resolução. Choque que não melhora durante transfusão maciça puxa para a ideia de que falta hemocomponente, e o INR de 1,4 parece pedir mais plasma. Mas os negativos no meio do caso dizem outra coisa: não há sangramento ativo pela sonda, a Hb está em 8,9, o fibrinogênio está acima de 150 e as plaquetas acima de 50.000, ou seja, as metas hemostáticas foram atingidas. O que sobra é o cálcio iônico de 0,78: cada unidade de hemácia e, sobretudo, de plasma traz citrato, que quela o cálcio, e o fígado do etilista em choque metaboliza mal o citrato. A hipocalcemia ionizada deprime a contratilidade, causa vasoplegia refratária à noradrenalina, alarga o QT e ainda prejudica a coagulação, porque o cálcio é cofator de várias etapas da cascata. A correção é cloreto de cálcio intravenoso (ou gluconato, em dose três vezes maior), com meta de cálcio iônico acima de 1,1 mmol/L e dosagens seriadas. Junto com a acidose e a hipotermia, a hipocalcemia completa o chamado diamante letal do sangramento.

A) Crioprecipitado, 10 unidades
Errada. Crioprecipitado se dá com fibrinogênio abaixo de 150 mg/dL na hemorragia ativa; aqui está em 190 e não há sangramento visível.

B) Nova unidade de concentrado de hemácias
Errada. A Hb de 8,9 g/dL sem sangramento ativo já está acima da meta de 7 a 9; mais hemácia traria mais citrato.

C) Cloreto de cálcio intravenoso CORRETA
Correta. Cálcio iônico de 0,78 mmol/L com choque refratário e QT longo durante transfusão maciça: cloreto de cálcio intravenoso, com meta acima de 1,1.

D) Mais 4 unidades de plasma ARMADILHA
Errada, é a armadilha. INR de 1,4 sem sangramento não pede plasma, e o plasma é o hemocomponente que mais carrega citrato: pioraria a hipocalcemia.

Para levar. Na transfusão maciça, medir o cálcio iônico a cada poucas unidades e repor com cálcio intravenoso para mantê-lo acima de 1,1 mmol/L: hipocalcemia pelo citrato causa choque refratário, QT longo e coagulopatia.

European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma, 6ª edição (Rossaint et al., Crit Care 2023); Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes, 2ª edição (2015).

28

Neurologia · Dor da polineuropatia diabética com depressão, clearance de 24 mL/min, glaucoma de ângulo fechado e BAV: pregabalina em dose reduzida, não duloxetina

Limiar **Gabarito A**

Homem de 68 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos, doença renal do diabetes com clearance de creatinina estimado de 24 mL/min e episódio depressivo leve diagnosticado há 1 mês, queixa-se de queimação e choques nos pés há 8 meses, piores à noite, que atrapalham o sono. Usa insulina NPH e regular, losartana, anlodipino e atorvastatina; tem hiperplasia prostática com jato fraco e glaucoma de ângulo fechado em acompanhamento. HbA1c 7,4%, B12 e TSH normais. Exame: hipoestesia em bota, aquileus abolidos, pulsos pediosos presentes, sem úlceras. ECG: bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Para a dor neuropática, a melhor opção inicial é:

O DADO QUE DECIDE

clearance de creatinina estimado de 24 mL/min

Resolução. Dor neuropática diabética com depressão é a deixa para a duloxetina, que trata as duas, e é a armadilha. As três classes de primeira linha (gabapentinoides, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, tricíclicos) têm eficácia parecida, e a escolha é decidida pelas contraindicações. A duloxetina deve ser evitada com clearance abaixo de 30 mL/min, e este paciente está em 24. A amitriptilina é anticolinérgica e piora retenção urinária na hiperplasia prostática, pode precipitar glaucoma de ângulo fechado e retarda a condução atrioventricular, que já tem bloqueio de primeiro grau. Resta a pregabalina, ajustada à função renal (com clearance entre 15 e 30, de 25 a 150 mg/dia), começando em dose baixa e subindo devagar.

A) Pregabalina 75 mg/dia CORRETA

Correta. Única das três classes de primeira linha sem contraindicação aqui, desde que em dose ajustada para clearance de 24 mL/min.

B) Duloxetina 60 mg/dia ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a escolha ideal com dor e depressão e clearance acima de 30; abaixo disso a duloxetina acumula e deve ser evitada.

C) Amitriptilina 25 mg à noite

Errada. Seria opção barata no paciente jovem sem cardiopatia; aqui há hiperplasia prostática, glaucoma de ângulo fechado e BAV, todos agravados pelo tricíclico.

D) Sertralina 50 mg/dia

Errada. Trataria a depressão, mas inibidor seletivo da recaptação de serotonina não tem eficácia relevante na dor neuropática.

Para levar. Na dor da polineuropatia diabética, a classe é escolhida pela contraindicação: duloxetina sai com clearance abaixo de 30, tricíclico sai com prostatismo, glaucoma de ângulo fechado ou distúrbio de condução, e a pregabalina entra com dose ajustada ao rim.

ADA Standards of Care in Diabetes 2025, seção 12 (Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care); Pop-Busui R et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the ADA. Diabetes Care 2017; bulas de duloxetina e pregabalina (ajuste renal).

29

Nefrologia · Disfunção do enxerto renal com tubulite e SV40 positivo · nefropatia por poliomavírus BK, e não rejeição a pulsar

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 52 anos, transplantado renal de doador falecido há nove meses, em uso de tacrolimo (vale de 7,8 ng/mL, alvo de 6 a 8), micofenolato de mofetila 1 g de 12/12 horas e prednisona 5 mg/dia. A creatinina subiu de 1,3 para 2,0 mg/dL em seis semanas, sem febre, com urina sem cilindros hemáticos e ultrassonografia sem hidronefrose. Anticorpos anti-HLA específicos do doador negativos. PCR para poliomavírus BK no plasma de 25.000 cópias/mL. A biópsia do enxerto mostra infiltrado intersticial com tubulite moderada, C4d negativo e imuno-histoquímica para SV40 positiva em núcleos de células tubulares. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

imuno-histoquímica para SV40 positiva em núcleos de células tubulares

Resolução. Infiltrado intersticial com tubulite é a lesão da rejeição celular aguda, e esse achado verdadeiro leva ao pulso de corticoide. Mas a nefropatia por BK produz a mesma inflamação tubulointersticial, e o que a separa é a demonstração do vírus no tecido: SV40 positivo nos núcleos tubulares, com viremia alta, C4d negativo e sem anticorpo específico do doador. Intensificar a imunossupressão nesse cenário acelera a replicação viral e a perda do enxerto. Não há antiviral com eficácia comprovada; a conduta é reduzir a imunossupressão, em geral suspendendo ou reduzindo o antimetabólito primeiro e depois baixando o alvo do inibidor de calcineurina, com PCR plasmática seriada.

A) Reduzir ou suspender o micofenolato CORRETA
Correta. Nefropatia por BK comprovada por SV40 se trata reduzindo a imunossupressão, a começar pelo micofenolato.

B) Pulsoterapia com metilprednisolona ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na rejeição celular aguda sem vírus no tecido; aqui o SV40 positivo explica a tubulite, e mais imunossupressão piora a doença.

C) Cidofovir intravenoso em dose baixa
Errada. Cidofovir não tem benefício comprovado e é nefrotóxico; fica, quando muito, como adjuvante após reduzir a imunossupressão.

D) Globulina antitimocitária
Errada. É tratamento de rejeição grave ou corticorresistente; intensificar a imunossupressão é o oposto do que a infecção pede.

Para levar. Tubulite no enxerto com viremia BK alta exige SV40 na biópsia; se positivo, o tratamento é reduzir a imunossupressão, e não pulsar.

Hirsch HH, Randhawa PS. BK polyomavirus in solid organ transplantation: AST IDCOP Guidelines 2019; KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients (2009).

30

Endocrinologia · Sela parcialmente vazia achada em ressonância de cefaleia, sem sinais clínicos: avaliação hormonal basal e nenhuma nova imagem

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 49 anos, hipertensa e obesa (IMC 36 kg/m²), fez ressonância de crânio para investigar cefaleia tensional de longa data, que melhorou com amitriptilina. O laudo descreve sela túrcica parcialmente vazia, com haste centrada e hipófise de 3 mm rechaçada contra o assoalho, sem lesões. Está na menopausa há 2 anos, amamentou os dois filhos sem dificuldade e não tem fadiga, poliúria, galactorreia nem alteração visual. PA 138 x 86 mmHg, FC 76 bpm; fundoscopia sem papiledema e campos visuais normais à confrontação. Sódio 139 mEq/L, glicemia 98 mg/dL. Ela traz o laudo preocupada com um tumor. O passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

sela túrcica parcialmente vazia, com haste centrada

Resolução. Um achado de imagem na sela costuma gerar a vontade de repetir a imagem, e essa é a armadilha. A sela parcialmente vazia é achado frequente em ressonâncias, sobretudo em mulheres obesas e hipertensas, e não é tumor nem tende a progredir; por isso não se programa nova ressonância. O que se recomenda é uma avaliação hormonal basal (cortisol às 8 horas, TSH e T4 livre, prolactina, IGF-1 e gonadotrofinas, que na menopausa devem estar altas e, se normais ou baixas, denunciam deficiência gonadotrófica), porque uma minoria tem hipopituitarismo parcial. Campimetria só se houver queixa visual ou herniação do quiasma, ausente aqui, e punção lombar só se houver papiledema ou sintomas de hipertensão intracraniana idiopática, que a fundoscopia normal e a cefaleia tensional controlada afastam. Com hormônios normais, ela recebe alta da investigação.

A) Avaliação hormonal basal da hipófise CORRETA
Correta. Sela vazia primária assintomática pede só a triagem hormonal basal; se normal, não há seguimento de imagem.

B) Nova ressonância de sela em 12 meses ARMADILHA
Errada. É a armadilha: repetir imagem é o seguimento do microadenoma ou macroadenoma não funcionante; sela vazia não progride.

C) Campimetria computadorizada seriada
Errada. Campimetria seria indicada com queixa visual ou herniação do quiasma na imagem; o campo é normal à confrontação.

D) Punção lombar com manometria
Errada. Manometria liquórica investiga hipertensão intracraniana idiopática, que exige papiledema ou sintomas compatíveis; aqui não há.

Para levar. Sela vazia primária achada sem sintomas: triagem hormonal basal e nada mais. Não é tumor e não pede imagem de controle.

Endocrine Society 2011 (Pituitary Incidentaloma); Endocrine Society 2016 (Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults).

---

31 Cardiologia · Bradicardia sinusal sintomática na idosa: suspender o anticolinesterásico e o colírio betabloqueador antes do marca-passo

Droga a deduzir **Gabarito D**

Mulher de 81 anos, com doença de Alzheimer leve e glaucoma de ângulo aberto, é trazida por tonturas há 3 semanas e um episódio de lipotimia ao caminhar. A filha conta que há 2 meses o neurologista iniciou um comprimido 'para a memória', com aumento da dose há 3 semanas, e que o oftalmologista mantém há anos um colírio que reduz a pressão do olho e que 'não pode ser usado por quem tem asma'. Usa também anlodipino 5 mg. PA 134×72 mmHg, FC 42 bpm, regular. ECG: bradicardia sinusal de 42 bpm, PR 190 ms, QRS 90 ms. Holter de 24 horas: FC mínima de 36 bpm em vigília, pausas sinusais de até 2,6 segundos, sem bloqueio atrioventricular. TSH 2,4 mUI/L, potássio 4,3 mEq/L, troponina normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

há 2 meses o neurologista iniciou um comprimido 'para a memória', com aumento da dose há 3 semanas

Resolução. Bradicardia sinusal sintomática com pausas puxa o marca-passo, que é a isca: a indicação existe, mas só depois de excluir causa reversível. Duas drogas bradicardizantes estão escondidas na história. O comprimido 'para a memória' na doença de Alzheimer é um inibidor da acetilcolinesterase (donepezila, rivastigmina ou galantamina), que aumenta o tônus vagal no nó sinusal e causa bradicardia e síncope, sobretudo após aumento de dose; a cronologia (sintomas 3 semanas após o aumento) amarra a causa. O colírio para glaucoma que não pode ser usado por asmáticos é o timolol, betabloqueador com absorção sistêmica pela mucosa nasal suficiente para bradicardia. A diretriz manda suspender ou substituir a droga e reavaliar (o colírio pode ser trocado por um análogo de prostaglandina); o marca-passo fica para a bradicardia que persiste sem ela ou quando a droga é indispensável.

A) Estudo eletrofisiológico da função sinusal
Errada. O estudo eletrofisiológico raramente é necessário na bradicardia sinusal com correlação sintoma-ritmo documentada no Holter, e não tem lugar antes de retirar as drogas.

B) Atropina e marca-passo transcutâneo
Errada. Atropina e marca-passo transcutâneo são para a bradicardia com instabilidade (hipotensão, choque, rebaixamento de consciência); ela está estável, com PA de 134×72 mmHg.

C) Implante de marca-passo definitivo ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O marca-passo seria a conduta na doença do nó sinusal sintomática sem causa reversível; aqui duas drogas bradicardizantes explicam o quadro e devem ser retiradas primeiro.

D) Retirar as drogas bradicardizantes e reavaliar CORRETA
Correta. O anticolinesterásico, com sintomas após o aumento de dose, e o timolol tópico são causas reversíveis de bradicardia; retirá-los (combinando com o neurologista e trocando o colírio por um análogo de prostaglandina) e repetir o Holter é o primeiro passo.

Para levar. Antes do marca-passo na bradicardia sintomática, procure a droga: anticolinesterásico para demência e colírio de timolol são causas reversíveis que a história esconde.

ACC/AHA/HRS 2018 Guideline on bradycardia and cardiac conduction delay; ESC 2021 Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy; Diretriz Brasileira de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis 2023

32

Gastroenterologia · Hematêmese recorrente com primeira endoscopia sem lesão e coágulos no fundo gástrico: nova endoscopia para lesão de Dieulafoy

Negativo no meio

Gabarito B

Homem de 71 anos, com doença renal crônica estágio 3b e cardiopatia isquêmica em uso de AAS, é internado com hematêmese volumosa e melena; PA 88×50 mmHg, FC 118 bpm. Após ressuscitação, faz endoscopia em 10 horas: grande quantidade de sangue fresco e coágulos em fundo e corpo gástricos, removidos parcialmente com lavagem; na mucosa visível, sem úlcera, varizes, erosões ou neoplasia; duodeno até a segunda porção normal. Estabiliza com 3 concentrados de hemácias. Trinta horas depois, nova hematêmese com queda da hemoglobina de 8,9 para 6,7 g/dL e PA 92×56 mmHg, que responde a volume. Colonoscopia há 1 ano normal. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

removidos parcialmente com lavagem

Resolução. Uma endoscopia que não achou a lesão empurra o raciocínio para fora do estômago: cápsula, angiotomografia ou colonoscopia. Mas aquela endoscopia foi incompleta: o fundo e o corpo estavam cobertos por coágulos removidos só em parte, exatamente onde se esconde a lesão de Dieulafoy, uma arteríola submucosa calibrosa que sangra por um defeito mínimo da mucosa, sangra de forma intermitente e maciça e costuma passar despercebida no primeiro exame. Hematêmese é sangramento proximal ao ângulo de Treitz, e ressangramento após endoscopia inconclusiva pede nova endoscopia precoce, com mais lavagem e mudança de decúbito, que acha a lesão na maioria das vezes e permite tratá-la com clipe ou terapia combinada. Angiotomografia e arteriografia ficam para quando a endoscopia não localiza ou não controla o sangramento. A colonoscopia não explica hematêmese.

A) Angiotomografia abdominal
Errada. É o passo quando uma endoscopia adequada não localiza a fonte ou falha no controle; aqui a primeira foi incompleta.

B) Nova endoscopia digestiva alta CORRETA
Correta. Exame inicial prejudicado por coágulos no fundo e no corpo, seguido de ressangramento: nova endoscopia precoce para achar e tratar a fonte, como a lesão de Dieulafoy.

C) Cápsula endoscópica do delgado ARMADILHA
Errada. É a armadilha. Cápsula investiga sangramento do delgado depois de endoscopia alta e colonoscopia adequadas e negativas; hematêmese aponta para cima.

D) Colonoscopia após preparo
Errada. Hematêmese localiza a fonte acima do ângulo de Treitz, e a colonoscopia de 1 ano atrás foi normal.

Para levar. Endoscopia alta inconclusiva por sangue e coágulos não é endoscopia negativa: no ressangramento, repetir a endoscopia antes de cápsula ou angiotomografia.

ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding (2021); ESGE Guideline: Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper GI hemorrhage (2021)

---

33 Reumatologia · Primeira recaída da polimialgia reumática na redução: voltar à última dose eficaz, e não reiniciar a dose de indução

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 72 anos, previamente hígida, tem polimialgia reumática diagnosticada há 7 meses, iniciada com prednisona 15 mg/dia e reduzida gradualmente, com remissão completa. Há 10 dias, 2 semanas após passar de 7,5 mg para 5 mg/dia, voltou a ter dor e rigidez matinal de 1 hora em cinturas escapular e pélvica. Nega cefaleia, alteração visual, claudicação de mandíbula ou de membros, febre e perda de peso. Usa cálcio e vitamina D. Exame físico: dor à mobilização ativa dos ombros, artérias temporais pulsáteis e indolores, pulsos e pressão arterial simétricos nos membros superiores. VHS 44 mm/h (era 12 mm/h), PCR 18 mg/L. É a primeira recaída. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

2 semanas após passar de 7,5 mg para 5 mg/dia

Resolução. Diante da recaída, o reflexo é recomeçar o tratamento do zero, voltando aos 15 mg da indução. As recomendações EULAR/ACR para polimialgia reumática pedem menos: aumentar o glicocorticoide para a dose em uso antes da recaída (aqui 7,5 mg/dia) e depois reduzir de novo, mais devagar, ao longo de 4 a 8 semanas até a dose em que a recaída ocorreu. A ausência de cefaleia, sintomas visuais, claudicação e assimetria de pulsos afasta arterite de células gigantes, que mudaria a dose. Anti-inflamatório não substitui o corticoide na polimialgia, e pulso não tem lugar. Metotrexato entra como poupador em quem recai repetidamente ou tem alto risco de efeito adverso.

A) Prednisona de volta a 15 mg/dia ARMADILHA
Errada. Seria a dose de início; na recaída basta voltar à última dose eficaz, o que poupa corticoide em idosa.

B) Prednisona de volta a 7,5 mg/dia CORRETA
Correta. Voltar à dose anterior à recaída e reduzir de novo mais lentamente é o que as recomendações pedem.

C) Manter 5 mg e associar naproxeno
Errada. AINE pode aliviar dor em casos selecionados, mas não controla a recaída da polimialgia.

D) Pulso de metilprednisolona
Errada. Pulso é para arterite de células gigantes com ameaça visual, ausente aqui.

Para levar. Recaída da polimialgia reumática: subir para a dose em uso antes da recaída e reduzir mais devagar; reiniciar a dose de indução é fazer mais do que o caso pede.

2015 EULAR/ACR recommendations for the management of polymyalgia rheumatica.

---

34 Hematologia · Febre em pessoa com HPN em uso de eculizumabe, mesmo vacinada: ceftriaxona imediata pelo risco meningocócico

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 29 anos, com hemoglobinúria paroxística noturna, recebe eculizumabe a cada 14 dias há 2 anos. Recebeu as vacinas meningocócicas ACWY e B antes do início do tratamento, com reforços em dia. Procura o pronto-socorro 6 horas após o início de febre de 38,9 °C, calafrios e mialgia intensa nas pernas. PA 104 × 62 mmHg, FC 112 bpm, FR 20 irpm, sem rigidez de nuca, sem petéquias, sem foco infeccioso aparente. Leucócitos 14.800/mm³ com desvio à esquerda, Hb 10,1 g/dL (estável), urina sem hemoglobinúria. Teste rápido para influenza negativo. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

recebe eculizumabe a cada 14 dias há 2 anos

Resolução. A vacinação completa é verdadeira e tranquiliza: com vacinas em dia e sem petéquias ou rigidez de nuca, parece um quadro viral a observar. Mas o inibidor do complemento terminal (C5) bloqueia o complexo de ataque à membrana, a defesa essencial contra Neisseria, e o risco de doença meningocócica continua centenas a milhares de vezes maior que o da população, porque as vacinas protegem de forma incompleta sem complemento funcional e não cobrem todos os sorogrupos. Febre com calafrios, taquicardia, mialgia intensa nas pernas e leucocitose são sinais iniciais de meningococcemia, antes das petéquias. A conduta é colher hemoculturas e dar ceftriaxona sem esperar, e os pacientes em uso de inibidor de C5 devem levar consigo um cartão de alerta e, em muitos serviços, antibiótico para iniciar ao primeiro sinal de febre. Antecipar a dose do eculizumabe trataria hemólise de escape, que não existe aqui.

A) Antecipar a dose de eculizumabe
Errada. Antecipar a dose seria a conduta na hemólise de escape (Hb caindo, hemoglobinúria); aqui a Hb está estável e o problema é infeccioso.

B) Hemoculturas e aguardar resultado
Errada. Colher hemoculturas está certo, mas esperar o resultado na suspeita de meningococcemia num paciente sem complemento terminal custa horas que definem a sobrevida.

C) Sintomáticos e reavaliação em 24 h ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria aceitável num imunocompetente com síndrome gripal; a vacina não protege totalmente quem usa inibidor de C5.

D) Hemoculturas e ceftriaxona imediata CORRETA
Correta. Febre em uso de eculizumabe é emergência: hemoculturas e ceftriaxona imediata, mesmo vacinado.

Para levar. Quem usa inibidor de C5 (eculizumabe, ravulizumabe) e tem febre recebe antibiótico com cobertura para meningococo imediatamente, mesmo com vacinação completa.

Brodsky RA, How I treat paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (Blood 2021); McNamara LA et al., High risk for invasive meningococcal disease among patients receiving eculizumab despite receipt of meningococcal vaccine (MMWR 2017).

35 Infectologia · Dengue com choque que persiste após dois bolus e hematócrito em queda: hemorragia oculta e concentrado de hemácias

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 32 anos, sem comorbidades, está no 5º dia de dengue confirmada por NS1. Chegou à emergência com extremidades frias, enchimento capilar de 4 segundos, PA 84 × 70 mmHg e FC 126 bpm; hematócrito de 50% e plaquetas de 34.000/mm³. Recebeu três bolus de 20 mL/kg de cristaloide em 1 hora, com diurese de 0,3 mL/kg/h. Na reavaliação: PA 80 × 60 mmHg, FC 132 bpm, extremidades ainda frias, sem sangramento exteriorizado, sem melena ao toque retal; o novo hematócrito caiu para 36%, e as plaquetas são 18.000/mm³. RNI 1,4, fibrinogênio 160 mg/dL. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

o novo hematócrito caiu para 36%

Resolução. A plaquetopenia de 18.000/mm³ e a falta de sangramento visível empurram para a transfusão de plaquetas ou para insistir no volume, mas o dado que decide é a direção do hematócrito diante da instabilidade. No choque da dengue, depois da expansão adequada, hematócrito em ascensão com choque persistente indica extravasamento contínuo e pede expansor plasmático (albumina); hematócrito em queda com choque persistente indica hemorragia, muitas vezes oculta (retroperitônio, trato digestivo ainda não exteriorizado), e pede concentrado de hemácias, além de avaliar a coagulopatia. O protocolo do Ministério da Saúde permite repetir a expansão até três vezes; esgotada essa fase sem resposta, é a direção do hematócrito que decide o passo seguinte. Uma queda de 50% para 36% em cerca de uma hora, sem melhora hemodinâmica, não se explica por hemodiluição. Transfusão de plaquetas não é guiada pela contagem na dengue e não corrige o choque; é considerada só no sangramento ativo com plaquetopenia grave, junto com a correção do resto. Novo bolus de cristaloide dilui ainda mais e piora o extravasamento.

A) Albumina 0,5 a 1 g/kg IV
Errada. Seria a escolha se o hematócrito estivesse subindo após a expansão, sinal de extravasamento persistente; aqui ele caiu.

B) Quarto bolus de cristaloide 20 mL/kg
Errada. Após três bolus sem resposta, já esgotada a fase de expansão do protocolo,, mais cristaloide com hematócrito em queda só dilui e alimenta o extravasamento, sem tratar a perda de sangue.

C) Concentrado de hemácias 10 a 15 mL/kg CORRETA
Correta. Choque persistente com hematócrito em queda após expansão adequada é hemorragia até prova em contrário, e o concentrado de hemácias é a reposição indicada.

D) Transfusão de concentrado de plaquetas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a contagem de plaquetas não indica transfusão na dengue, e plaquetas não corrigem o choque hemorrágico.

Para levar. Na dengue com choque que não responde à expansão, a direção do hematócrito decide: subindo, albumina; caindo, procurar hemorragia e transfundir hemácias. A contagem de plaquetas, sozinha, não indica transfusão.

Ministério da Saúde, Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança, 6ª ed. (2024); OMS, Handbook for clinical management of dengue (2012).

36 Pneumologia · Crise de asma na gestante: PaCO2 de 40 mmHg é retenção, não normalidade

Limiar **Gabarito B**

Gestante de 26 anos, com 31 semanas, asmática, chega com crise há 10 horas, sem melhora após três ciclos de salbutamol inalatório. Está consciente, fala frases curtas e usa musculatura acessória. FR 30 irpm, FC 118 bpm, SpO2 93% em ar ambiente; sibilos difusos de intensidade reduzida. Pico de fluxo 45% do melhor valor pessoal. Gasometria arterial em ar ambiente: pH 7,40, PaCO2 40 mmHg, PaO2 68 mmHg, HCO3 24 mEq/L. A interpretação mais adequada da gasometria é:

O DADO QUE DECIDE

PaCO2 40 mmHg

Resolução. Os valores parecem normais pela régua de fora da gestação, e é isso que atrai a alternativa da gasometria normal. A progesterona aumenta a ventilação-minuto, e a gestante saudável vive com PaCO2 de 28 a 32 mmHg, bicarbonato de 18 a 21 mEq/L e pH discretamente alcalino. Numa crise de asma, a hiperventilação deveria baixar ainda mais o CO2; PaCO2 de 40 mmHg nessa gestante significa que ela já não consegue sustentar o trabalho respiratório, sinal de insuficiência respiratória iminente. Somam-se a PaO2 abaixo de 70 mmHg (que na gestação compromete o feto) e o pico de fluxo de 45%. Ela precisa de tratamento máximo (corticoide sistêmico, ipratrópio, magnésio), alvo de SpO2 de pelo menos 95% e vigilância em ambiente de terapia intensiva.

A) Alcalose respiratória esperada da gestação
Errada. Seria a leitura com PaCO2 próxima de 30 mmHg; com 40 mmHg o CO2 está alto para a gestante.

B) Retenção de CO2 com fadiga iminente CORRETA
Correta. Na gestação a PaCO2 basal é de 28 a 32 mmHg; 40 mmHg durante uma crise indica fadiga e falência iminente.

C) Acidose metabólica associada à crise
Errada. Bicarbonato de 24 mEq/L e pH 7,40 não mostram acidose metabólica; o problema é o CO2 retido.

D) Gasometria normal, sem gravidade adicional ARMADILHA
Errada. Normal fora da gestação; aqui é o limiar de gravidade que mais se perde.

Para levar. Na gestante, PaCO2 normal é 28 a 32 mmHg: numa crise de asma, CO2 de 35 a 40 mmHg já é retenção e indica insuficiência respiratória iminente.

GINA 2024 (asma na gestação e manejo da exacerbação); ACOG Practice Bulletin 90, Asthma in Pregnancy (reafirmado).

---

37 Neurologia · Crises distônicas faciobraquiais com hiponatremia anterior à carbamazepina: encefalite anti-LGI1, não crise provocada pelo sódio

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 63 anos, hipertenso em uso de losartana, é internado por 'epilepsia focal refratária'. Há 6 semanas tem episódios de 1 a 2 segundos de contração tônica do braço e da hemiface esquerdos, às vezes com a perna, até 60 vezes por dia, sem perda de consciência; há 3 semanas, a esposa nota esquecimento de fatos recentes e irritabilidade. Já usou levetiracetam e carbamazepina em doses plenas, sem redução dos episódios. Afebril, PA 132/80 mmHg, sem déficit focal entre os episódios. Sódio 127 mEq/L (antes do início da carbamazepina, 129

mEq/L), osmolalidade urinária 410 mOsm/kg, TSH e cortisol normais. EEG interictal normal; um episódio registrado sem correlato eletrográfico claro. RM: discreto hipersinal em T2/FLAIR no hipocampo direito. Líquor: 3 células/mm³, proteína 48 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

(antes do início da carbamazepina, 129 mEq/L)

Resolução. Carbamazepina e sódio de 127 puxam para a crise provocada por hiponatremia, e é exatamente a regra que ele erra ao contrário. O dado entre parênteses derruba a tese: a hiponatremia já existia antes da droga, e um sódio de 127 a 129 de instalação lenta não provoca dezenas de crises por dia. O quadro é de crises distônicas faciobraquiais (contrações de 1 a 2 segundos, braço e face do mesmo lado, dezenas por dia, muitas vezes sem correlato no EEG), seguidas de déficit de memória recente, com hiponatremia por secreção inapropriada de ADH e hipersinal hipocampal: encefalite límbica anti-LGI1, em que o líquor costuma ser normal. Essas crises respondem mal a droga anticrise e bem a imunoterapia (corticoide, imunoglobulina), e tratá-las cedo evita a progressão para a amnésia. A esclerose hipocampal não explica o início aos 63 anos com declínio subagudo, e a Creutzfeldt-Jakob não cursa com crises distônicas faciobraquiais nem com hiponatremia.

A) Crises por hiponatremia da carbamazepina ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a resposta se o sódio tivesse caído depois da droga e de forma aguda; aqui já era 129 antes da carbamazepina e não explica crises de 2 segundos dezenas de vezes ao dia.

B) Epilepsia temporal por esclerose hipocampal
Errada. Esclerose hipocampal dá crises focais de início na juventude, com aura e perda de contato, e não amnésia subaguda aos 63 anos com hiponatremia.

C) Doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica
Errada. Creutzfeldt-Jakob daria demência rapidamente progressiva com mioclonias e EEG periódico, sem crises faciobraquiais nem secreção inapropriada de ADH.

D) Encefalite autoimune anti-LGI1 CORRETA
Correta. Crises distônicas faciobraquiais refratárias a anticrise, amnésia recente, hiponatremia prévia e hipersinal hipocampal definem a encefalite anti-LGI1.

Para levar. Contrações de 1 a 2 segundos de braço e face, dezenas por dia, com hiponatremia e perda de memória: anti-LGI1; a hiponatremia é parte da doença, não a causa das crises, e o tratamento é imunoterapia.

Graus F et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol 2016; Irani SR et al. Faciobrachial dystonic seizures. Ann Neurol 2011.

---

38 Nefrologia · Cistinúria com cálculos novos apesar de hidratação e pH urinário no alvo · associar tiol, e não alcalinizar além de 7,5

Limiar **Gabarito C**

Homem de 24 anos, com cálculos renais desde os 14 anos (cinco episódios de cólica e duas ureterolitotripsias), pai e um irmão também litiásicos. A análise de um cálculo expelido identificou cistina. Há oito meses segue ingestão hídrica de 4 L/dia, dieta com restrição de sódio (sódio urinário de 95 mEq/dia) e citrato de potássio em dose plena. Nova tomografia sem contraste mostra dois cálculos novos, de 6 e 8 mm, no rim esquerdo. Urina de

24 horas: volume 3,6 L, cistina 720 mg/dia, cálcio 180 mg/dia, citrato 820 mg/dia; pH urinário de 7,6 em três medidas domiciliares. Creatinina 0,9 mg/dL, potássio 4,6 mEq/L. Além de manter as medidas atuais, a conduta mais adequada para prevenir novos cálculos é:

O DADO QUE DECIDE

pH urinário de 7,6 em três medidas domiciliares

Resolução. A armadilha é fazer mais do mesmo: se a alcalinização ajuda, mais álcali ajudaria mais. Só que o alvo do pH urinário na cistinúria é de 7,0 a 7,5, e ele já está em 7,6. Acima disso o ganho de solubilidade da cistina é pequeno, e o pH muito alto favorece cálculo de fosfato de cálcio e sobrecarga de potássio. Com volume urinário acima de 3 L, sódio restrito e pH no alvo, a formação de cálculos novos indica falha das medidas conservadoras, e o degrau seguinte é mudar de classe: um tiol (tiopronina, preferida à D-penicilamina pela tolerância) forma dissulfeto solúvel com a cisteína. Cálcio urinário de 180 mg/dia é normal, o que tira o lugar do tiazídico.

A) Elevar o citrato até pH acima de 8,0 ARMADILHA
Errada. Seria a conduta se o pH estivesse abaixo de 7,0; com 7,6 o alvo já foi atingido, e subir mais aumenta o risco de cálculo de fosfato de cálcio.

B) Associar acetazolamida à noite
Errada. A acetazolamida alcaliniza a urina à custa de acidose metabólica e hipocitratúria, favorece cálculo de fosfato de cálcio e não é recomendada na cistinúria.

C) Associar tiopronina oral CORRETA
Correta. Cálculos novos com hidratação, restrição de sódio e pH no alvo pedem a droga tiol, que reduz a cistina livre na urina.

D) Associar hidroclorotiazida em dose baixa
Errada. Tiazídico é para hipercalciúria com cálculo de cálcio; aqui o cálcio urinário é de 180 mg/dia e o cálculo é de cistina.

Para levar. Na cistinúria, a ordem é volume urinário acima de 3 L, restrição de sódio e citrato até pH de 7,0 a 7,5; se ainda formar cálculo, associa-se tiol (tiopronina), e não mais álcali.

AUA Guideline on Medical Management of Kidney Stones (2014, revisão 2019); EAU Guidelines on Urolithiasis 2024.

---

39 Endocrinologia · Fibrose tireoidiana que ultrapassa a cápsula com fibrose retroperitoneal e anti-TPO positivo: tireoidite de Riedel, glicocorticoide

Grade X / Y **Gabarito B**

Mulher de 47 anos refere aumento progressivo do pescoço há 10 meses, com rouquidão há 2 meses e dispneia ao deitar. Há 3 anos fez nefrostomia bilateral por hidronefrose causada por fibrose retroperitoneal, em acompanhamento. Exame: tireoide aumentada de forma difusa, pétrea, indolor, aderida aos planos profundos e sem mobilidade à deglutição; sem linfonodos palpáveis; afebril. TSH 7,8 mUI/L, T4 livre 0,9 ng/dL (referência 0,9 a 1,8), anti-TPO 210 UI/mL (referência até 35), VHS 32 mm/h. Duas punções aspirativas foram não diagnósticas por material acelular. A biópsia incisional mostrou fibrose densa hialinizada que ultrapassa a cápsula e invade a musculatura pré-tireoidiana, flebite oclusiva e infiltrado linfoplasmocitário com mais de 30 plasmócitos IgG4 positivos por campo, sem atipias. O diagnóstico e o tratamento clínico de primeira linha são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

fibrose densa hialinizada que ultrapassa a cápsula

Resolução. Anti-TPO alto e TSH elevado são verdadeiros e puxam para Hashimoto na variante fibrosante, que também dá bócio firme. O dado que separa está na biópsia: na variante fibrosante de Hashimoto a fibrose fica contida dentro da cápsula; na tireoidite de Riedel ela ultrapassa a cápsula e invade as estruturas vizinhas, com flebite oclusiva. A fibrose retroperitoneal prévia e os plasmócitos IgG4 positivos completam o quadro de fibrose multifocal da doença relacionada a IgG4, da qual Riedel faz parte. A punção acelular é esperada num tecido tão fibroso, e por isso a biópsia incisional foi necessária. O tratamento de primeira linha é o glicocorticoide (prednisona), com tamoxifeno como alternativa ou adjuvante e rituximabe nos refratários; levotiroxina corrige o hipotireoidismo, mas não trata a fibrose, e cirurgia limita-se a desobstruir a via aérea (istmectomia).

A) Hashimoto fibrosante / levotiroxina ARMADILHA
Errada. É a armadilha: anti-TPO e TSH alto são verdadeiros, mas na variante fibrosante de Hashimoto a fibrose não ultrapassa a cápsula; levotiroxina não age na fibrose invasiva.

B) Tireoidite de Riedel / prednisona CORRETA
Correta. Fibrose que invade além da cápsula, flebite oclusiva, IgG4 e fibrose retroperitoneal: Riedel, tratada inicialmente com glicocorticoide.

C) Carcinoma anaplásico / quimiorradioterapia
Errada. O anaplásico cresce em semanas, em idosos, e a biópsia mostra células com atipia acentuada, fusiformes e gigantes; aqui não há atipias.

D) Linfoma primário da tireoide / R-CHOP
Errada. Linfoma tireoidiano surge sobre Hashimoto com crescimento rápido e infiltrado linfoide monoclonal; a biópsia mostra fibrose, e não população linfoide monoclonal.

Para levar. Bócio pétreo, fixo e invasivo com punção acelular: biópsia incisional. Fibrose além da cápsula e fibrose retroperitoneal associada é Riedel (espectro IgG4), tratada com glicocorticoide.

Khosroshahi e cols., International Consensus Guidance Statement on the Management and Treatment of IgG4-Related Disease (Arthritis Rheumatol 2015); Critérios de classificação ACR/EULAR 2019 da doença relacionada a IgG4.

40

Reumatologia · Poliangeíte microscópica escondida sob o rótulo de fibrose pulmonar idiopática: hematúria dismórfica pede ANCA antes de LBA ou biópsia pulmonar

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Homem de 69 anos, ex-tabagista, recebeu há 8 meses diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática por tomografia com padrão de pneumonia intersticial usual, sem biópsia, e aguarda o início de antifibrótico. Nega exposição a aves, mofo, poeiras ocupacionais, amiodarona e nitrofurantoína; sem Raynaud, artrite, lesões de pele ou fraqueza. Há 2 meses tem astenia, perda de 5 kg e febre baixa vespertina. Exame físico: PA 152 × 90 mmHg, estertores em velcro em bases, sem baqueteamento digital. Exames: Hb 10,4 g/dL, creatinina 1,9 mg/dL (0,9 mg/dL há 8 meses), urina tipo 1 com 40 hemácias por campo, 70% dismórficas, e proteína 2+; PCR 64 mg/L; FAN e fator reumatoide não reagentes. O exame a solicitar agora é:

O DADO QUE DECIDE

70% dismórficas

Resolução. O rótulo de fibrose pulmonar idiopática é verdadeiro para a imagem (padrão de pneumonia intersticial usual), e por isso o raciocínio fica preso ao pulmão: lavado, biópsia, antifibrótico. Mas o caso trouxe sintomas constitucionais, anemia, perda de função renal e hematúria com hemácias dismórficas: há glomerulonefrite. Fibrose pulmonar com padrão de pneumonia intersticial usual pode ser a primeira manifestação da poliangeíte microscópica com anti-MPO, às vezes anos antes do rim, e o ANCA deve fazer parte da avaliação de toda doença intersticial. O ANCA por ELISA (anti-MPO e anti-PR3) é o próximo passo, rápido e não invasivo; positivo, segue a biópsia renal, que define atividade e prognóstico. Lavado e biópsia pulmonar não explicam o rim.

A) Biópsia pulmonar cirúrgica
Errada. Serviria a uma doença intersticial indefinida sem pista sistêmica; aqui é invasiva e não explica a glomerulonefrite.

B) Lavado broncoalveolar com celularidade ARMADILHA
Errada. Útil para pneumonite de hipersensibilidade ou infecção; a exposição foi negada e o problema novo está no rim.

C) ANCA com anti-MPO e anti-PR3 CORRETA
Correta. Glomerulonefrite com pneumonia intersticial usual em idoso é poliangeíte microscópica até prova em contrário: anti-MPO.

D) Ultrassonografia renal com Doppler
Errada. Seria o primeiro exame numa lesão renal sem sedimento ativo; hematúria dismórfica aponta lesão glomerular, não obstrutiva ou vascular.

Para levar. Doença intersticial com padrão de pneumonia intersticial usual e hematúria dismórfica é poliangeíte microscópica até prova em contrário: peça ANCA (anti-MPO) antes de qualquer procedimento pulmonar.

ACR/EULAR classification criteria for microscopic polyangiitis (2022); ATS/ERS/JRS/ALAT IPF guideline (2022); KDIGO Glomerular Diseases (2024).

41

Hepatologia · Prurido no terceiro trimestre com ácidos biliares acima de 100 µmol/L: colestase intra-hepática da gestação com parto programado entre 35 e 36 semanas

Grade X / Y **Gabarito D**

Gestante de 31 anos, G2P1, com 33 semanas, refere prurido intenso em palmas e plantas há 2 semanas, pior à noite, sem lesões cutâneas além de escoriações. Nega náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia ou polidipsia. PA 118×72 mmHg. Exames: ALT 186 U/L, AST 140 U/L, bilirrubina total 1,4 mg/dL, plaquetas 228.000/mm³, glicemia 82 mg/dL, creatinina 0,6 mg/dL, ácido úrico 4,1 mg/dL, INR 1,0, proteinúria negativa e ácidos biliares séricos totais de 118 µmol/L. Sorologias para hepatites virais negativas. Ultrassonografia: vesícula com microcálculos, vias biliares não dilatadas. O diagnóstico e a programação do parto são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

ácidos biliares séricos totais de 118 µmol/L

Resolução. Prurido palmoplantar noturno no terceiro trimestre, aminotransferases altas e ácidos biliares elevados, sem hipertensão, plaquetopenia, hipoglicemia ou coagulopatia, é colestase intra-hepática da gestação; os microcálculos são achado comum e não explicam colestase sem dilatação das vias. Quem acerta o diagnóstico tende a marcar o parto a termo, que vale para a forma leve. O risco fetal (morte intrauterina súbita) cresce com o pico de ácidos biliares, e acima de 100 µmol/L ele sobe de forma clara: as diretrizes recomendam programar o parto entre 35 e 36 semanas, enquanto com pico abaixo de 100 µmol/L o parto pode ser programado entre 38 e 39 semanas. A esteatose aguda teria hipoglicemia, coagulopatia e insuficiência hepática, e a HELLP, hipertensão, hemólise e plaquetopenia. O ursodesoxicólico pode aliviar o prurido, mas não muda o momento do parto.

A) Esteatose hepática aguda da gestação / parto imediato
Errada. Esteatose aguda da gestação traria hipoglicemia, INR alargado, lesão renal e encefalopatia; glicemia 82 e INR 1,0 a afastam.

B) Colestase intra-hepática da gestação / parto com 38 a 39 semanas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o diagnóstico está certo, mas 38 a 39 semanas vale para pico abaixo de 100 µmol/L; 118 µmol/L pede antecipação.

C) Síndrome HELLP / parto com 34 semanas
Errada. HELLP exige hemólise e plaquetopenia, em geral com hipertensão; plaquetas 228.000 e PA normal a afastam.

D) Colestase intra-hepática da gestação / parto entre 35 e 36 semanas CORRETA
Correta. Colestase intra-hepática da gestação com ácidos biliares acima de 100 µmol/L: risco de óbito fetal alto e parto programado entre 35 e 36 semanas.

Para levar. Na colestase da gestação, o pico de ácidos biliares define o parto: acima de 100 µmol/L, programar entre 35 e 36 semanas.

RCOG Green-top Guideline No. 43: Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy (2022); SMFM Consult Series No. 53: Intrahepatic cholestasis of pregnancy (2021)

---

42 Cardiologia · Filho assintomático de portador de ATTR hereditária com variante conhecida: teste genético dirigido antes de qualquer imagem

Omissão **Gabarito B**

Homem de 41 anos, negro, assintomático, procura o cardiologista porque o pai, de 68 anos, acaba de receber o diagnóstico de amiloidose cardíaca por transtirretina: cintilografia com pirofosfato grau 3, imunofixação sérica e urinária negativas, cadeias leves livres normais e sequenciamento do gene TTR heterozigoto para a variante Val142Ile (antiga V122I). O pai operou túnel do carpo aos 58 anos e tem dispneia desde os 64. O paciente corre 5 km três vezes por semana e nega parestesias, dormência nas mãos, diarreia, tontura ao levantar ou dispneia. PA 124×78 mmHg, FC 62 bpm, exame físico normal. ECG: ritmo sinusal, voltagem normal, sem áreas inativas. Ecocardiograma: septo de 9 mm, FE 63%, strain longitudinal global normal e sem preservação apical. NT-proBNP 36 pg/mL. O médico do convênio sugere 'cintilografia com pirofosfato já, para pegar a doença no início'. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

sequenciamento do gene TTR heterozigoto para a variante Val142Ile

Resolução. A cintilografia com pirofosfato é a isca: foi o exame que fechou o diagnóstico do pai, e a vontade de achar a doença cedo empurra para ela. Mas num parente de 41 anos assintomático, com ECG, ecocardiograma com strain e NT-proBNP normais, a chance de captação é mínima, e a pergunta que muda a conduta vem antes: ele herdou a variante? Como a variante da família é conhecida, o teste genético dirigido a ela, precedido de aconselhamento genético, responde isso com uma coleta de sangue. Se ele não for portador, sai do seguimento; se for, entra em vigilância com ECG, ecocardiograma com strain e NT-proBNP, e a cintilografia passa a ser pedida quando surgir alteração ou ao se aproximar da idade em que a doença apareceu na família (em geral a partir de cerca de 10 anos antes dela). A Val142Ile, frequente em afrodescendentes, tem penetrância incompleta e dependente da idade: o genótipo isolado não é doença e não indica tratamento. Não pedir nada, por outro lado, tira do portador a chance de diagnóstico precoce.

A) Ressonância cardíaca com mapa T1
Errada. A ressonância com mapa T1 procura infiltração quando há suspeita clínica ou alteração no eco; num jovem com exames normais não acrescenta, e não diz se ele herdou a variante.

B) Teste genético dirigido à variante paterna CORRETA
Correta. Com a variante familiar conhecida, o teste dirigido define quem precisa de vigilância: é o degrau mais simples e o que muda a conduta.

C) Nenhum exame enquanto assintomático
Errada. Seria aceitável se o pai tivesse a forma selvagem, que não se herda; com variante patogênica, os parentes de primeiro grau têm indicação de aconselhamento e teste genético.

D) Cintilografia com pirofosfato de tecnécio ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A cintilografia entra no portador com sinais de doença ou perto da idade de início na família; no assintomático de 41 anos, com exames normais e genótipo desconhecido, é exame a mais.

Para levar. Parente de primeiro grau de ATTR hereditária com variante conhecida: aconselhamento e teste genético dirigido primeiro; só o portador entra em vigilância (ECG, eco com strain, NT-proBNP e, no momento certo, cintilografia).

ESC Working Group position statement on diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis (Garcia-Pavia P et al., Eur Heart J 2021); ACC Expert Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis, 2023; ESC 2023 Guidelines for the management of cardiomyopathies (avaliação genética de familiares)

---

43 Infectologia · Febre de origem indeterminada sem pista localizadora após investigação de primeira linha: PET-CT antes das biópsias às cegas

Dado omitido **Gabarito B**

Homem de 58 anos, contador, apresenta febre diária de até 38,6 °C há 5 semanas, com sudorese noturna e perda de 4 kg. Está internado há 8 dias para investigação: três pares de hemoculturas negativos, ecocardiograma transtorácico normal, sorologias para HIV, hepatites B e C, sífilis e toxoplasmose não reagentes, FAN e fator reumatoide negativos, urina tipo 1 e urocultura normais, TC de tórax, abdome e pelve sem alterações. Hemograma sem citopenias, fosfatase alcalina e transaminases normais, VHS 88 mm/h, PCR 9 mg/dL, ferritina 640 ng/mL. Ao exame, não há sopro, linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia, lesões de pele, artrite ou alteração de pulsos. Não viajou, não tem animais e não usa medicamentos. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Hemograma sem citopenias, fosfatase alcalina e transaminases normais

Resolução. A biópsia hepática foi por décadas o passo seguinte na febre de origem indeterminada, e a de medula e a de artéria temporal são lembradas porque granulomatoses, linfoma e arterite de células gigantes estão entre as causas. Mas biópsia às cegas rende pouco quando nada aponta o órgão, e o que este caso tem de decisivo é exatamente o que falta: nenhuma citopenia que leve à medula, nenhuma alteração de enzimas canaliculares que leve ao fígado, nenhuma cefaleia, claudicação mandibular ou alteração visual que leve à temporal. Depois da investigação de primeira linha negativa, o PET-CT com FDG é o exame com maior rendimento diagnóstico, porque localiza linfoma, vasculite de grandes vasos (inclusive aortite que a TC não mostrou), infecção profunda e neoplasia oculta, e orienta onde biopsiar. Um PET-CT negativo também tem valor, por indicar evolução benigna na maioria dos casos.

A) Biópsia de medula óssea
Errada. Teria rendimento se houvesse citopenia, esplenomegalia ou suspeita de doença granulomatosa disseminada no imunossuprimido, ausentes aqui.

B) PET-CT com FDG CORRETA
Correta. Sem pista localizadora após a investigação inicial, o PET-CT localiza o processo e aponta o alvo da biópsia.

C) Biópsia hepática percutânea ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a biópsia hepática faz sentido com fosfatase alcalina ou GGT elevadas ou hepatomegalia, e o caso tem enzimas normais.

D) Biópsia de artéria temporal
Errada. Seria o caminho com cefaleia, claudicação mandibular, alteração visual ou artéria temporal anormal; sem essas pistas, o PET-CT ainda detecta a vasculite de grandes vasos.

Para levar. Na febre de origem indeterminada sem pista localizadora após a primeira linha, o PET-CT com FDG vem antes de qualquer biópsia às cegas; biópsia é dirigida pelo achado.

Haidar G, Singh N. Fever of unknown origin. N Engl J Med 2022; Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022), capítulo de febre de origem indeterminada.

---

44 Hematologia · Medula hipocelular com micromegacariócitos e monossomia do 7: síndrome mielodisplásica hipocelular, e não anemia aplástica

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 64 anos, com astenia há 4 meses e duas internações por pneumonia no período. Nega etilismo, quimioterapia, radioterapia ou exposição a solventes, e não usa medicamentos. Exame físico com palidez, sem esplenomegalia ou linfonodomegalias. Hemograma: Hb 7,8 g/dL, VCM 109 fL, reticulócitos 0,4%, leucócitos 2.100/mm³ (neutrófilos 700/mm³), plaquetas 34.000/mm³. Vitamina B12, folato, cobre, TSH e função hepática normais; sorologias para HIV e hepatites virais negativas. Biópsia de medula: celularidade de 15%, com micromegacariócitos e megacariócitos hipolobulados em meio ao estroma gorduroso, blastos 3%, sem fibrose. Citometria de fluxo do sangue periférico: clone HPN de 1,5% nos granulócitos. Cariótipo da medula: 45,XY,-7 em 12 de 20 metáfases. O diagnóstico e o achado que o sustenta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

45,XY,-7 em 12 de 20 metáfases

Resolução. Pancitopenia com medula de 15% de celularidade evoca anemia aplástica, e o clone HPN pequeno parece confirmá-la, porque aparece em até metade dos casos de aplasia. Mas a medula hipocelular é comum às duas doenças, e o clone HPN, embora mais frequente na aplasia, também ocorre na síndrome mielodisplásica (SMD): ele não separa. O que separa é a displasia megacariocítica (micromegacariócitos e formas hipolobuladas não fazem parte da aplasia, em que megacariócitos quase desaparecem) e, sobretudo, a monossomia do 7, alteração citogenética definidora de neoplasia mieloide, associada a evolução para leucemia e a má resposta à imunossupressão. O diagnóstico é SMD hipocelular, cujo tratamento e prognóstico diferem: a imunossupressão com ATG e ciclosporina não é a via principal com monossomia do 7, e o transplante alogênico deve ser discutido cedo. A macrocitose também combina mais com SMD, embora apareça na aplasia.

A) Anemia aplástica / clone HPN ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Clone HPN pequeno favorece aplasia, mas não exclui SMD; com displasia de megacariócitos e -7, o diagnóstico muda.

B) Anemia aplástica / monossomia do 7
Errada. Monossomia do 7 é critério de neoplasia mieloide; não convive com o rótulo de anemia aplástica.

C) Síndrome mielodisplásica hipocelular / clone HPN
Errada. O diagnóstico está certo, mas o clone HPN não é o que sustenta SMD; é achado inespecífico entre as duas.

D) Síndrome mielodisplásica hipocelular / monossomia do 7 CORRETA
Correta. Medula hipocelular com micromegacariócitos e monossomia do 7 em metade das metáfases: SMD hipocelular.

Para levar. Medula hipocelular não é sinônimo de anemia aplástica: displasia megacariocítica e citogenética anormal (monossomia do 7, del(7q)) definem SMD hipocelular; clone HPN pequeno não decide.

Classificação OMS de neoplasias hematolinfoides, 5ª edição (2022); British Society for Haematology, Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia (2024 update).

45

Pneumologia · Granulomatose eosinofílica com poliangeíte com miocardite: doença grave pede ciclofosfamida, e não o biológico da asma

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 44 anos, com asma iniciada aos 38 anos, em uso de budesonida-formoterol em dose alta, rinossinusite crônica e polipose nasal. Há 6 semanas tem febre baixa, perda de 5 kg, parestesias e queda do pé esquerdo; há 5 dias, dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores. PA 108/70 mmHg, FC 112 bpm. Eosinófilos 4.800/mm³ (31%), creatinina 0,9 mg/dL, sedimento urinário sem hematúria, ANCA negativo. TC de tórax: opacidades em vidro fosco periféricas. Troponina T ultrassensível 210 ng/L (ref. < 14), BNP 1.400 pg/mL; ecocardiograma com FE de 32% e hipocinesia difusa; coronariografia sem lesões. O tratamento de indução mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

FE de 32% e hipocinesia difusa

Resolução. Asma tardia, polipose, eosinofilia acima de 10%, infiltrados pulmonares e mononeurite múltipla fecham granulomatose eosinofílica com poliangeíte, mesmo com ANCA negativo (que é a regra em cerca de 60% dos casos). O rótulo verdadeiro é a asma eosinofílica grave, que puxa o mepolizumabe: ele é aprovado para a doença, mas para a forma sem ameaça a órgão ou à vida. Aqui há miocardite com FE de 32%, a principal causa de morte na doença e critério de gravidade (Five-Factor Score). Doença grave se induz com pulso de glicocorticoide associado a ciclofosfamida (ou rituximabe); no ANCA negativo com acometimento cardíaco, a ciclofosfamida é a escolha mais apoiada. O mepolizumabe entra depois, na manutenção ou na recidiva não grave. Corticoide isolado é insuficiente com acometimento cardíaco e neurológico.

A) Pulso de metilprednisolona e ciclofosfamida CORRETA
Correta. Miocardite com FE de 32% e neuropatia: doença grave, indução com pulso de corticoide e ciclofosfamida.

B) Prednisona oral isolada
Errada. Seria aceitável na doença sem acometimento de órgão vital; com miocardite, corticoide isolado deixa a doença ativa.

C) Mepolizumabe 300 mg e prednisona ARMADILHA
Errada. É a indução da forma não grave (asma, sinusite, pele) e a manutenção; não substitui a imunossupressão na miocardite.

D) Omalizumabe e corticoide inalatório
Errada. Anti-IgE para asma alérgica grave; não trata vasculite e não tem papel na indução.

Para levar. Na EGPA, o tratamento depende da gravidade, não da asma: coração, rim, sistema nervoso ou trato digestivo acometidos pedem corticoide com ciclofosfamida ou rituximabe; mepolizumabe é da doença não grave e da manutenção.

ACR/Vasculitis Foundation Guideline for ANCA-Associated Vasculitis (2021); EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis, 2022 update.

46

Gastroenterologia · Disfagia com contrações prematuras e relaxamento incompleto da junção em usuário crônico de opioide: disfunção esofágica induzida por opioide, e não espasmo primário

Droga a deduzir | **Gabarito A**

Homem de 58 anos tem há 5 meses disfagia para sólidos e líquidos e episódios de dor retroesternal em aperto durante as refeições. Há 8 meses, depois de uma artrodese lombar, toma diariamente um comprimido de liberação prolongada prescrito pelo ortopedista para a dor da coluna, que também lhe trouxe constipação, hoje controlada com macrogol. Cateterismo recente sem lesões coronarianas. Peso estável. Endoscopia normal, com biópsias esofágicas sem eosinófilos; esofagograma sem estenose; TC de tórax e abdome superior normal. Glicemia e TSH normais. Manometria de alta resolução: pressão de relaxamento integrada (IRP) de 19 mmHg (normal até 15 mmHg) e 40% das deglutições com contrações prematuras (latência distal menor que 4,5 s), com peristaltismo normal nas demais. A causa mais provável do quadro é:

O DADO QUE DECIDE

toma diariamente um comprimido de liberação prolongada prescrito pelo ortopedista para a dor da coluna, que também lhe trouxe constipação

Resolução. Contrações prematuras em 40% das deglutições levam direto ao espasmo esofagiano distal, e é essa a leitura de quem olha só o laudo. Mas o espasmo distal primário exige relaxamento normal da junção, e aqui a IRP está elevada; a acalasia tipo III, por sua vez, exige ausência de peristaltismo normal, e as demais deglutições foram normais. O dado que amarra o quadro está na história: um comprimido de liberação prolongada para dor crônica que causou constipação é um opioide. Os opioides agonistas mu aumentam o tônus da junção e encurtam a latência distal, produzindo um padrão manométrico que imita espasmo, acalasia tipo III ou obstrução do fluxo da junção, e a Classificação de Chicago 4.0 manda considerar a disfunção induzida por opioide antes de rotular um distúrbio primário. A conduta é reduzir ou retirar o opioide e repetir a manometria, antes de qualquer miotomia ou dilatação. Pseudoacalasia fica improvável com endoscopia, TC e peso normais.

A) Efeito do opioide sobre a motilidade esofágica CORRETA

Correta. O opioide crônico, deduzido pelo comprimido para dor que causou constipação, explica IRP alta com contrações prematuras e peristaltismo parcialmente preservado.

B) Acalasia tipo III idiopática

Errada. Seria a resposta com 100% de falha do peristaltismo normal; aqui as deglutições sem contração prematura foram normais, e há uma droga que reproduz o padrão.

C) Pseudoacalasia por neoplasia da cárdia

Errada. Seria a hipótese no idoso com disfagia curta e emagrecimento; peso estável, endoscopia e TC normais a afastam.

D) Espasmo esofagiano distal primário ARMADILHA

Errada. É a armadilha do laudo. O espasmo distal primário tem IRP normal e não pode ser diagnosticado em uso de opioide sem antes retirá-lo.

Para levar. Contração prematura ou IRP alta na manometria de quem usa opioide crônico: pensar em disfunção esofágica induzida por opioide, retirar a droga e repetir o exame antes de tratar distúrbio primário.

Chicago Classification of Esophageal Motility Disorders v4.0 (2021); ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Achalasia (2020)

---

47 Neurologia · Hemorragia intracerebral em uso de varfarina com prótese mecânica: complexo protrombínico de 4 fatores e vitamina K IV, a prótese não impede a reversão

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 71 anos, com prótese mecânica mitral e fibrilação atrial em uso de varfarina, e com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 25%, é trazido 90 minutos após o início de hemiparesia esquerda e sonolência. PA 178/96 mmHg, FC 88 bpm irregular, SatO2 95% em ar ambiente, estertores em bases. Glasgow 13. TC de crânio: hematoma capsulonuclear direito de 22 mL, sem extensão ventricular. RNI 2,8; plaquetas 210.000/mm³; creatinina 1,3 mg/dL. Peso 80 kg. O agente para reverter a anticoagulação e o uso de vitamina K são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

RNI 2,8

Resolução. A armadilha é a prótese mecânica: o medo de trombose valvar leva a reverter só com o complexo protrombínico e poupar a vitamina K. Na hemorragia intracerebral em uso de antagonista da vitamina K, o risco imediato de expansão do hematoma supera o risco de trombose da prótese em poucos dias, e a reversão tem de ser completa e sustentada. O complexo protrombínico de 4 fatores corrige o RNI em minutos, mas seus fatores duram de 6 a 8 horas; sem vitamina K IV o RNI volta a subir, por isso as duas vão juntas. Plasma fresco é inferior (corrige devagar, exige grande volume) e aqui ainda carrega 1.200 mL para um coração com fração de ejeção de 25% e congestão. A anticoagulação da prótese é retomada depois, em geral entre 1 e 2 semanas, conforme o hematoma.

A) Complexo protrombínico de 4 fatores / vitamina K 10 mg IV CORRETA
Correta. Complexo protrombínico de 4 fatores reverte rápido, e a vitamina K IV impede o rebote quando os fatores infundidos acabarem, mesmo com prótese mecânica.

B) Plasma fresco congelado 15 mL/kg / vitamina K 10 mg IV
Errada. Plasma seria a opção só sem complexo protrombínico disponível; é lento, e 15 mL/kg em fração de ejeção de 25% com estertores precipita edema pulmonar.

C) Complexo protrombínico de 4 fatores / sem vitamina K ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Acerta o agente, mas sem vitamina K o RNI volta a subir em horas; a prótese não justifica reversão incompleta de uma hemorragia intracraniana.

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg / sem vitamina K
Errada. Combina o agente mais lento com a reversão que não se sustenta: dois erros.

Para levar. Hemorragia intracerebral com varfarina: complexo protrombínico de 4 fatores mais vitamina K 10 mg IV, sempre juntos, mesmo com prótese mecânica; plasma só na falta do complexo.

AHA/ASA 2022 Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage; ESO Guideline on reversal of oral anticoagulants in acute intracerebral haemorrhage 2019; Diretrizes da SBC sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia 2013.

48

Nefrologia · Hipocalemia com hipomagnesemia e hipocalciúria em jovem preocupada com o peso · pesquisar diurético na urina antes do teste genético

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 29 anos, técnica de enfermagem, com cãibras e fraqueza há quatro meses. Nega vômitos, diarreia, uso de laxantes ou de diuréticos, e conta que vive preocupada com o peso (IMC 19 kg/m²). PA 98/62 mmHg, sem edema, sem erosões dentárias. Exames repetidos em três ocasiões, com resultados semelhantes: potássio 2,7 mEq/L, bicarbonato 32 mEq/L, magnésio 1,3 mg/dL (1,7 a 2,4), creatinina 0,7 mg/dL, cloro urinário em amostra isolada 78 mEq/L, relação cálcio/creatinina urinária 0,03 mg/mg, renina e aldosterona elevadas. Pais não consanguíneos, sem casos semelhantes na família. O exame a solicitar a seguir é:

O DADO QUE DECIDE

vive preocupada com o peso (IMC 19 kg/m²)

Resolução. Hipocalemia com alcalose, PA baixa, cloro urinário alto, hipomagnesemia e hipocalciúria compõem o fenótipo de Gitelman, e esses achados reais puxam direto para o teste genético. Só que o uso escondido de tiazídico produz exatamente o mesmo quadro, inclusive a hipocalciúria e a hipomagnesemia, e esta paciente tem acesso fácil a medicamentos e preocupação com o peso, sem história familiar. Antes do sequenciamento (caro, demorado e que pode vir inconclusivo), a diretriz de consenso pede excluir diurético com pesquisa em urina, de preferência em mais de uma amostra, porque o uso pode ser intermitente. Vômitos escondidos também imitam o quadro, mas dariam cloro urinário baixo, e aqui ele é de 78 mEq/L. Relação aldosterona/renina não ajuda: as duas estão altas.

A) Sequenciamento do gene SLC12A3 ARMADILHA
Errada. Confirma Gitelman, mas é o degrau seguinte; sem afastar diurético, um resultado inconclusivo não encerra a dúvida.

B) Pesquisa de diuréticos na urina CORRETA
Correta. Uso escondido de tiazídico reproduz o fenótipo inteiro e se exclui com pesquisa urinária, repetida se preciso.

C) Relação aldosterona/renina
Errada. Serve para hiperaldosteronismo primário, que cursa com hipertensão e renina suprimida; aqui a PA é baixa e a renina, alta.

D) Teste de sobrecarga com tiazídico
Errada. O teste com tiazídico ajuda a separar Gitelman de Bartter, mas não separa Gitelman do uso escondido de diurético.

Para levar. Fenótipo de Gitelman em adulto sem história familiar exige excluir diurético escondido (pesquisa urinária) e vômitos (cloro urinário) antes do teste genético.

Blanchard A et al. Gitelman syndrome: consensus and guidance from a KDIGO Controversies Conference. Kidney Int 2017.

49

Reumatologia · Artrite psoriásica com acometimento axial e psoríase extensa: anti-IL-17, e não o anti-IL-12/23 que trata a pele mas falha no esqueleto axial

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 41 anos tem psoríase em placas há 15 anos, com 18% da superfície corporal acometida, e artrite psoriásica há 3 anos. Usa metotrexato 20 mg/semana com ácido fólico há 7 meses, com melhora parcial da pele, mas persiste com artrite de duas interfalangeanas distais e dactilite do 3º pododáctilo esquerdo. Há 1 ano surgiu dor lombar e glútea alternante, que o acorda de madrugada e melhora com o movimento; a ressonância de sacroilíacas mostra edema ósseo subcondral bilateral. Sem doença inflamatória intestinal, uveíte, insuficiência cardíaca ou doença desmielinizante; IGRA, HBsAg e anti-HCV negativos. O dermatologista que o acompanha sugere ustequinumabe, com o qual teve ótimos resultados em pele. A escolha mais adequada para o próximo passo é:

> O DADO QUE DECIDE
> *a ressonância de sacroilíacas mostra edema ósseo subcondral bilateral*

Resolução. A psoríase extensa e a sugestão do dermatologista puxam para o ustequinumabe, que de fato controla bem a pele, a artrite periférica e a dactilite. O dado que decide está no meio do caso: há doença axial

ativa, com dor lombar inflamatória e sacroiliíte na ressonância. Os inibidores de IL-12/23 (ustequinumabe) e de IL-23 falharam nos ensaios de espondiloartrite axial e não são recomendados quando o esqueleto axial está acometido. Com falha do metotrexato, doença axial e psoríase extensa, os inibidores de IL-17 (ixequizumabe, secuquinumabe) ou um anti-TNF são as escolhas, e o anti-IL-17 tem a vantagem do efeito cutâneo mais intenso. Apremilaste e leflunomida não agem na doença axial.

A) Apremilaste
Errada. Opção oral para doença periférica e cutânea leve a moderada; sem eficácia axial e menos potente que biológico.

B) Ixequizumabe CORRETA
Correta. Anti-IL-17 trata pele extensa, entesite, dactilite, artrite periférica e a doença axial.

C) Leflunomida
Errada. DMARD sintético para artrite periférica; não age na sacroiliíte nem na pele extensa.

D) Ustequinumabe ARMADILHA
Errada. Seria excelente sem doença axial, sobretudo com pele extensa; os inibidores de IL-12/23 falham na espondiloartrite axial.

Para levar. Na artrite psoriásica, antes de escolher o biológico, pergunte pelo esqueleto axial: com sacroiliíte, anti-IL-17 ou anti-TNF; o anti-IL-12/23 e o anti-IL-23 ficam para doença periférica e cutânea.

GRAPPA treatment recommendations for psoriatic arthritis (2021); EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis (2023 update).

---

50 Endocrinologia · Calcitonina detectável abaixo de 150 pg/mL após tireoidectomia por carcinoma medular: ultrassonografia cervical, e não estadiamento sistêmico

Limiar **Gabarito D**

Homem de 44 anos foi submetido, há 4 meses, a tireoidectomia total com esvaziamento do compartimento central por carcinoma medular esporádico de 2,1 cm (pesquisa germinativa de RET negativa), com 2 de 14 linfonodos centrais comprometidos. Antes da cirurgia, a calcitonina era de 1.240 pg/mL e o CEA de 18 ng/mL. Está assintomático, em uso de levotiroxina 125 µg/dia, com TSH de 1,6 mUI/L e cálcio normal. Exame cervical sem nódulos palpáveis. Exames atuais: calcitonina 86 pg/mL (referência abaixo de 10) e CEA 4,1 ng/mL (referência abaixo de 5). O exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
calcitonina 86 pg/mL

Resolução. Calcitonina ainda detectável após a cirurgia indica doença residual, e o reflexo é estadiar o corpo todo, que é a armadilha. No carcinoma medular, o nível pós-operatório guia a extensão da busca: abaixo de 150 pg/mL, a doença persistente está quase sempre no pescoço, e o exame indicado é a ultrassonografia cervical, seguida de calcitonina e CEA a cada 6 meses para calcular o tempo de duplicação. Acima de 150 pg/mL, aí sim, procuram-se metástases a distância com TC de pescoço e tórax, RM ou TC trifásica de fígado e RM de coluna e pelve ou cintilografia óssea. A queda de 1.240 para 86 pg/mL e o CEA normalizado reforçam doença de baixo volume. Iodo radioativo não tem papel, porque a célula C não capta iodo.

A) Pesquisa de corpo inteiro com iodo-131

Errada. Pesquisa com iodo-131 serve ao carcinoma diferenciado de origem folicular; a célula C do medular não concentra iodo.

B) PET-CT com FDG de corpo inteiro

Errada. PET com FDG tem baixa sensibilidade no medular de baixo volume e fica para doença avançada com duplicação rápida dos marcadores.

C) TC de tórax e RM de fígado ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o estadiamento sistêmico é a conduta quando a calcitonina pós-operatória passa de 150 pg/mL; com 86, a busca começa no pescoço.

D) Ultrassonografia cervical CORRETA

Correta. Calcitonina detectável, mas abaixo de 150 pg/mL: ultrassonografia cervical e seguimento dos marcadores a cada 6 meses.

Para levar. Carcinoma medular operado: calcitonina indetectável é cura bioquímica; detectável abaixo de 150 pg/mL, ultrassonografia cervical; acima de 150, imagem sistêmica.

ATA 2015 (Revised Guidelines for the Management of Medullary Thyroid Carcinoma); NCCN Thyroid Carcinoma 2025.